



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE MEDICINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE

MESTRADO PROFISSIONAL



MARIANE LOPES DA SILVA GUIMARÃES FROTA CORDEIRO

**ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO ENSINO TÉCNICO DE UM INSTITUTO
FEDERAL: CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE UM INSTRUMENTO PARA
QUALIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA**

Porto Alegre
2026

MARIANE LOPES DA SILVA GUIMARÃES FROTA CORDEIRO

**ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO ENSINO TÉCNICO DE UM INSTITUTO
FEDERAL: CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE UM INSTRUMENTO PARA
QUALIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA**

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ensino na Saúde – pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Linha de Pesquisa: Processos de Ensino na Saúde.

Orientadora: Profa. Dra. Fabiana Schneider Pires.

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Cordeiro , Mariane Lopes da Silva Guimarães Frota
ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO ENSINO TÉCNICO DE UM
INSTITUTO FEDERAL: construção colaborativa de um instrumento para
qualificação da documentação clínica / Mariane Lopes da Silva Guimarães
Frota Cordeiro .

-- 2026.

85 f.

Orientador: Fabiana Schneider Pires.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ensino na Saúde, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Registros de Enfermagem. 2. Educação em Enfermagem. 3. Segurança do
Paciente. 4. Manuais como Assunto. I. Schneider Pires, Fabiana, orient. II.
Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

MARIANE LOPES DA SILVA GUIMARÃES FROTA CORDEIRO

**ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO ENSINO TÉCNICO DE UM INSTITUTO
FEDERAL: CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE UM INSTRUMENTO PARA
QUALIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA**

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ensino na Saúde – pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Linha de Pesquisa: Processos de Ensino na Saúde.

Aprovada em: 17/04/2026

Banca examinadora:

Orientadora. Profa. Dra. Fabiana Schneider Pires
PPGENSAU/UFRGS.

Prof. Dr. Rafael Arenhaldt
PPGENSAU/UFRGS.

Profa. Dra. Gisele Cristina Tertuliano
PPGENSAU/UFRGS.

Profa. Dra. Nadine de Biagi Ziesemer
Instituto Federal Do Paraná – IFPR.

Profa. Dra. Maria Aparecida de Oliveira. Suplente
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

À minha mãe, Angélica, pelo dom da vida e pelo cuidado ao longo de toda esta trajetória. Ao meu pai, Ruben, pela escuta atenta, pelo apoio e pelo incentivo que, no decorrer deste percurso, tornaram-se fundamentais para a conclusão deste trabalho. À minha avó, professora Dinalva, referência de estudo, dedicação e sensibilidade, cuja trajetória docente inspira reflexões sobre educar e cuidar. Aos encontros que a vida tece no tempo certo, que aprofundaram vínculos, trouxeram histórias e revelaram afinidades, dando sentidos profundos à minha formação.

AGRADECIMENTOS

Registro minha gratidão à professora Fabiana Schneider Pires, que esteve ao meu lado durante todo o desenvolvimento deste trabalho. Sua escuta atenta, suas observações sempre cuidadosas e a confiança construída ao longo do percurso foram fundamentais para que esta pesquisa ganhasse forma, consistência e direção.

À minha família, deixo um agradecimento especial. O apoio incondicional, a paciência nos momentos em que precisei me dedicar com mais intensidade e o cuidado carinhoso tornaram possível seguir em frente. Vocês foram presença constante, amparo e força ao longo dessa trajetória.

Aos docentes e colegas do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, agradeço pelas aulas, pelas reflexões e pelo rigor acadêmico que contribuíram para o amadurecimento deste estudo. Sou grata também pelas conversas, pelas trocas generosas e pelo companheirismo, que tornaram os desafios compartilhados e o caminho menos solitário.

Aos colegas docentes do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, minha gratidão pela disponibilidade e generosidade em participar desta pesquisa. As experiências, inquietações e saberes que compartilharam deram sentido concreto a este trabalho. O convívio cotidiano e o incentivo constante tornaram essa caminhada mais leve e significativa. Este estudo também é fruto das construções que fazemos juntos, dia após dia.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, estiveram presentes nesse percurso. Este trabalho não se constrói apenas nas páginas que o compõem, mas nas relações, nos apoios e nos aprendizados que o tornaram possível.

RESUMO

A documentação de enfermagem integra a continuidade do cuidado, a comunicação interprofissional e a segurança do paciente, compondo parte significativa dos registros em prontuários. Observam-se, contudo, deficiências recorrentes quanto à incompletude dos registros, ao uso inadequado da terminologia técnico-científica e à ausência de padronização. Este estudo teve por objetivo desenvolver, de forma colaborativa, um manual de Anotações de Enfermagem para o Curso Técnico em Enfermagem do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, como recurso pedagógico fundamentado em evidências científicas, normativas profissionais e percepções docentes. Trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa. Participaram nove docentes enfermeiros, selecionados por amostragem intencional: oito integrantes de grupo focal e um colaborador por relato individual complementar. O corpus discursivo foi analisado segundo a Análise de Discurso. Do estudo emergiram três categorias temáticas: organização curricular e abordagem pedagógica dos registros; fragilidades percebidas na documentação elaborada pelos estudantes; e proposições para materiais didáticos e recursos pedagógicos. Com base nos achados empíricos, nas Resoluções do COFEN e em revisão integrativa da literatura, foi elaborado manual estruturado, com linguagem adequada ao nível técnico, organização didática e exemplos práticos contextualizados. O produto visa contribuir para a organização dos registros, o aprimoramento do raciocínio clínico e o cumprimento das exigências éticas e legais da documentação em enfermagem.

Palavras-chave: registros de enfermagem; educação em enfermagem; segurança do paciente; manuais como assunto.

ABSTRACT

Nursing documentation integrates care continuity, interprofessional communication, and patient safety, comprising a significant portion of medical record entries. However, recurring deficiencies are observed regarding incomplete records, inadequate use of technical-scientific terminology, and lack of standardization. This study aimed to collaboratively develop a Nursing Notes manual for the Technical Nursing Course at the Federal Institute of Paraná, Curitiba Campus, as a pedagogical resource grounded in scientific evidence, professional regulations, and faculty perceptions. This is a qualitative, exploratory, and descriptive study, approved by a Research Ethics Committee. Nine nurse educators participated, selected through intentional sampling: eight focus group members and one collaborator through an individual complementary report. The discursive corpus was analyzed using Discourse Analysis. Three thematic categories emerged: curricular organization and pedagogical approaches to nursing records; perceived weaknesses in documentation produced by students; and proposals for teaching materials and pedagogical resources. Based on empirical findings, COFEN Resolutions, and an integrative literature review, a structured manual was developed with language appropriate to the technical level, didactic organization, and contextualized practical examples. The product aims to contribute to the organization of records, the improvement of clinical reasoning, and compliance with the ethical and legal requirements of nursing documentation.

Keywords: nursing records; nursing education; patient safety; manuals as topic.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese das bases normativas nacionais e internacionais sobre documentação de enfermagem (ordem cronológica)17

Quadro 2 – Caracterização dos participantes do grupo focal39

Quadro 3 – Síntese das categorias temáticas emergentes da análise do discurso41

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA	American Nurses Association
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CEB	Câmara de Educação Básica
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNE	Conselho Nacional de Educação
COFEN	Conselho Federal de Enfermagem
COREN	Conselho Regional de Enfermagem
EPS	Educação Permanente em Saúde
ICN	International Council of Nurses
IF	Instituto Federal
IFPR	Instituto Federal do Paraná
JCI	Joint Commission International
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
PE	Processo de Enfermagem
PEC	Prontuário Eletrônico do Cidadão
PEP	Prontuário Eletrônico do Paciente
PPC	Projeto Pedagógico de Curso
ProfEPT	Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica
SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TDIC	Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
TE	Técnico de Enfermagem
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E APROXIMAÇÃO COM O OBJETO DE ESTUDO

Minha trajetória profissional iniciou-se em 2005, com a formação como Técnica em Enfermagem, seguida pela graduação em Fisioterapia. Desde então, atuei na prática clínica e também na elaboração de protocolos e materiais educativos voltados à organização de processos assistenciais.

Em 2010, ingressei como servidora pública, integrando a equipe do Centro de Material e Esterilização da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, participei da construção de protocolos de biossegurança, padronização de fluxos de trabalho e produção de materiais educativos destinados a estudantes. Essa experiência me fez perceber a importância de instrumentos pedagógicos estruturados para a formação profissional e para o fortalecimento da segurança do paciente. A especialização em Saúde Pública, concluída na UFRGS, ampliou essa compreensão ao aprofundar temas relacionados à gestão de processos em saúde, aos sistemas de informação e à documentação clínica como componentes da continuidade e da qualidade do cuidado.

Em 2024, passei a atuar no Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, junto ao Curso Técnico em Enfermagem, com atividades vinculadas aos laboratórios. Nesse espaço participo da organização de cenários simulados e observo o percurso formativo dos estudantes. Ouvindo relatos de alguns membros do corpo docente percebi a existência de fragilidades recorrentes na elaboração dos registros de enfermagem pelos estudantes, aspecto que passou a orientar minha inquietação investigativa.

A identificação dessas dificuldades, associada à experiência prévia na elaboração de protocolos e materiais educativos e à constatação da escassez de instrumentos pedagógicos específicos para o ensino das anotações no nível técnico, convergiu para a construção deste estudo. A pesquisa reúne, portanto, minha vivência como técnica de enfermagem, a formação em saúde pública, a atuação no apoio pedagógico e o compromisso com a qualificação da formação profissional em enfermagem.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
1.1 OBJETIVOS	15
1.1.1 Objetivo geral.....	15
1.1.2 Objetivos específicos.....	15
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	16
2.1 DOCUMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM: FUNDAMENTOS, BASES NORMATIVAS E SEGURANÇA DO PACIENTE	16
2.1.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem, Processo de Enfermagem e documentação.....	21
2.1.2 Registros de enfermagem, segurança do paciente e qualidade da assistência	22
2.2 FORMAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM	24
2.2.1 Formação técnica em enfermagem no contexto brasileiro	24
2.2.2 Ensino das anotações de enfermagem e estratégias pedagógicas na formação técnica	26
2.2.3 Institutos Federais e produção de materiais.....	28
2.2.4 O Instituto Federal do Paraná e o Curso Técnico em Enfermagem.....	29
2.3 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA DOCUMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM	30
2.3.1 Prontuário eletrônico	31
2.3.2 Manuais como tecnologias educacionais na formação profissional.....	32
3 METODOLOGIA	35
3.1 TIPO DE ESTUDO E DESENHO METODOLÓGICO.....	35
3.2 CENÁRIO E PARTICIPANTES	36
3.3 PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS.....	36
3.4 ASPECTOS ÉTICOS.....	37
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	39
4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES	39
4.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: ENTRE PROGRESSÃO E FRAGMENTAÇÃO	41

4.3 DIFICULDADES DISCENTES: DÉFICITS DE BASE E DESAFIOS COGNITIVOS	45
4.4 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E LACUNAS MATERIAIS	49
4.5 FORMAÇÃO DOCENTE: SABERES CONSTRUÍDOS NA PRÁXIS	53
4.6 SÍNTESE DOS ACHADOS E IMPLICAÇÕES PARA O PRODUTO EDUCACIONAL	55
4.6.1 Limitações do estudo.....	57
4.6.2 Contribuições do estudo	58
5 PRODUTO TÉCNICO	60
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	62
REFERÊNCIAS.....	64
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	75
APÊNDICE B – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL	77
APÊNDICE C – MODELO DE CONVITE AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOCAL	78
APÊNDICE D – CARTAZ DE CONVITE.....	79
ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA.....	80
ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP	81
ANEXO C – FICHA TÉCNICA DO PRODUTO EDUCACIONAL.....	83
ANEXO D - TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ	84

1 INTRODUÇÃO

O Processo de Enfermagem (PE) é definido pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) como uma metodologia sistemática aplicada ao cuidado, fundamentada em bases teóricas, sistemas de classificação e protocolos científicos, cuja implementação constitui atribuição privativa do enfermeiro (COFEN, 2024a). Embora essa responsabilidade recaia sobre esse profissional, os Técnicos de Enfermagem (TE) participam do desenvolvimento do processo por meio da execução das intervenções prescritas e da produção de registros que subsidiam a coleta de dados e a avaliação dos resultados da assistência.

A Resolução COFEN nº 736/2024, em seu artigo 8º, determina que todas as etapas do PE sejam formalizadas no prontuário do paciente, (COFEN, 2024a), em consonância com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que estabelece como dever da equipe o registro claro, objetivo, completo e cronológico das informações inerentes ao cuidado (COFEN, 2017). No âmbito da formação profissional, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos prevê que o técnico em enfermagem desenvolva competências relacionadas à comunicação, ao trabalho em equipe e ao uso de tecnologias da informação, habilidades diretamente vinculadas à produção e ao compartilhamento de registros clínicos (Brasil, 2020).

Apesar da existência de diretrizes normativas e formativas, pesquisas nacionais apontam fragilidades persistentes na documentação produzida por técnicos de enfermagem. Ferreira *et al.* (2020) identificaram não conformidades em registros hospitalares, como ausência de identificação profissional em 41,8% dos casos e falta de horário em 76,6%. Quanto à completude, Dodo *et al.* (2020), observaram que apenas 25,9% dos registros analisados estavam completos, enquanto 67,1% apresentavam lacunas.

Tais inadequações produzem repercussões nos serviços de saúde. Santos *et al.* (2025) relatam que falhas nos registros contribuem para a ocorrência de glosas hospitalares, impactando o faturamento institucional. Além do efeito econômico, registros inadequados ou incompletos podem comprometer a segurança do paciente e a proteção legal dos profissionais, ao dificultarem a rastreabilidade das ações realizadas e o atendimento às exigências éticas da profissão (Silva; Araújo, 2025).

Esses problemas observados na prática profissional têm relação com desafios apontados na formação técnica em enfermagem, na qual estudos nacionais descrevem fragilidades relacionadas à organização curricular, à formação pedagógica dos docentes e ao envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem (Fioramonte; Marin; Pinto, 2022; Góis; Azevedo; Rodrigues, 2022).

No Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, a matriz curricular contempla componentes relacionados ao processo de trabalho em enfermagem e à documentação do cuidado, conforme previsto no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) (IFPR, 2023). Ainda assim, a presença formal desses conteúdos no currículo não garante, por si só, a efetividade dos processos de ensino-aprendizagem, especialmente diante da recorrência das fragilidades documentais descritas em estudos nacionais e das observações empíricas realizadas por docentes nos campos de estágio.

Diante desse cenário, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: como os professores de um curso técnico em enfermagem de um Instituto Federal (IF) percebem o ensino das anotações de enfermagem e quais estratégias pedagógicas e materiais didáticos podem contribuir para o aprimoramento desse processo?

Para os fins deste estudo, compreendem-se como anotações de enfermagem os registros descritivos realizados pelos membros da equipe de enfermagem no prontuário do paciente, físico ou eletrônico, abrangendo informações sobre o estado de saúde, procedimentos executados, intercorrências observadas e cuidados prestados. Esse escopo distingue-se das etapas do PE que envolvem julgamento clínico e são privativas do enfermeiro, especificamente o Diagnóstico de Enfermagem e a Prescrição de Enfermagem, conforme estabelecido pela Resolução COFEN nº 736/2024 (COFEN, 2024a).

Com vistas a responder à questão proposta, o presente estudo tem como finalidade o desenvolvimento de um Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem, concebido como produto educacional e fundamentado nas percepções dos professores do curso técnico em enfermagem do IFPR, Campus Curitiba. A escolha do formato manual decorre da necessidade de sistematizar orientações atualmente dispersas em diferentes fontes e de sua viabilidade como instrumento permanente de apoio ao ensino, tanto em sala de aula quanto nos campos de prática.

A relevância da pesquisa manifesta-se ao contribuir para o debate sobre o ensino das anotações de enfermagem na formação técnica, ao responder à necessidade de qualificação da documentação produzida por técnicos de enfermagem e ao alinhar-se ao compromisso dos IFs com a formação profissional orientada às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

1.1 OBJETIVOS

A seguir serão apresentados o objetivo geral e objetivos específicos do trabalho.

1.1.1 Objetivo geral

Conhecer as dificuldades e potencialidades da qualificação da documentação clínica do Curso Técnico em Enfermagem do IFPR a partir das percepções docentes, analisadas junto às evidências científicas e normativas profissionais da Enfermagem.

1.1.2 Objetivos específicos

A seguir os objetivos específicos:

- a) analisar diretrizes e normativas profissionais que orientam a elaboração de anotações de enfermagem quanto à qualidade e à padronização da documentação clínica;
- b) compreender as percepções e práticas de docentes do IFPR relacionadas ao ensino das anotações de enfermagem na formação técnica;
- c) identificar aspectos técnicos, formais e ético-legais envolvidos na documentação clínica produzida por estudantes do curso técnico, a partir das percepções docentes;
- d) elaborar um manual estruturado, com linguagem acessível, organização didática e exemplos contextualizados, aplicável às atividades práticas e aos estágios do curso técnico em enfermagem.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A análise do ensino das anotações de enfermagem na formação técnica exige a compreensão dos referenciais que estruturam a documentação profissional no campo da saúde. Nesse sentido, torna-se necessário examinar os fundamentos normativos, éticos e conceituais que orientam a produção dos registros, bem como sua relação com a organização do cuidado e com a segurança do paciente. Considerando que a educação profissional técnica de nível médio forma a maior parcela da força de trabalho da enfermagem no país, torna-se igualmente relevante situar esse debate no contexto das diretrizes que orientam a formação do técnico em enfermagem.

2.1 DOCUMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM: FUNDAMENTOS, BASES NORMATIVAS E SEGURANÇA DO PACIENTE

A documentação de enfermagem constitui componente do exercício profissional, integrando o processo de cuidado ao registrar formalmente as ações realizadas, as observações clínicas e as respostas do paciente às intervenções de enfermagem. Sua realização é orientada por parâmetros éticos e legais que definem responsabilidades e critérios formais de qualidade, tendo sido recentemente atualizada com a normatização do uso de prontuários eletrônicos e plataformas digitais pelo COFEN em 2024 (Amadei, 2024; COFEN, 2024b; Sales *et al.*, 2025).

Além de viabilizarem a comunicação efetiva entre a equipe multiprofissional, os registros apresentam múltiplas finalidades, que abrangem ensino, pesquisa, auditoria e planejamento. Por sua natureza de documento legal, representam parcela significativa das informações contidas no prontuário e atuam como meio de respaldo e defesa profissional (COFEN, 2016, 2023).

Sob essa perspectiva, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017) estabelece como dever fundamental do profissional: “Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras” (COFEN, 2017, art. 36).

Essa determinação está prevista no Decreto nº 94.406/1987, cujo art. 14, inciso II, atribui a todo o pessoal de enfermagem a responsabilidade de “[...] anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem” (Brasil, 1987, art. 14). Embora o texto original apresente escopo restrito a fins estatísticos, normativas posteriores ampliaram as finalidades da documentação, conforme estabelecido nas Resoluções COFEN nº 736/2024 e nº 754/2024, cujas exigências também se estendem ao ambiente digital, com regulamentação específica para prontuários eletrônicos e demais tecnologias de informação em saúde, conforme será abordado na seção 2.3.1 (COFEN, 2024a, 2024b).

O Quadro 1 reúne, em ordem cronológica, os dispositivos mencionados, permitindo uma visão integrada do percurso normativo que orienta a documentação de enfermagem.

Quadro 1 – Síntese das bases normativas nacionais e internacionais sobre documentação de enfermagem (ordem cronológica)

Norma / Documento	Ano	Âmbito	Contribuições para a documentação
Lei nº 5.905 (Brasil, 1973).	1973	Nacional	Institui o Sistema COFEN/COREN e define competências normativas e fiscalizatórias da profissão.
Lei nº 7.498 (Brasil, 1986).	1986	Nacional	Regulamenta o exercício profissional da enfermagem e suas atividades.
Decreto nº 94.406 (Brasil, 1987).	1987	Nacional	Dispõe sobre o exercício da enfermagem e prevê a anotação de enfermagem no prontuário do paciente.
American Nurses Association (ANA) – Documentation Principles (ANA, 2010).	2010	Internacional	Estabelece diretrizes para a documentação como parte do exercício profissional da enfermagem.
Resolução COFEN nº 514 (Guia de Recomendações para os Registros de Enfermagem) (COFEN, 2016).	2016	Nacional	Guia orientador que estabelece critérios formais e diferenciação entre tipos de registros de enfermagem.

Norma / Documento	Ano	Âmbito	Contribuições para a documentação
Resolução COFEN nº 564 (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem) (COFEN, 2017).	2017	Nacional	Estabelece deveres éticos relacionados ao registro claro, completo, legível e cronológico das informações de enfermagem.
Lei nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) (Brasil, 2018a).	2018	Nacional	Define princípios de proteção, confidencialidade e tratamento de dados pessoais, aplicáveis às informações em saúde.
International Council of Nurses (ICN) – Code of Ethics for Nurses (ICN, 2021).	2021	Internacional	Define princípios éticos relacionados à confidencialidade, veracidade e uso adequado das informações em enfermagem.
Recomendações COFEN para os Registros de Enfermagem no Exercício da Profissão (COFEN, 2023).	2023	Nacional	Atualiza e consolida diretrizes para os registros de enfermagem no exercício profissional.
Resolução COFEN nº 736 (COFEN, 2024a).	2024	Nacional	Normatiza o Processo de Enfermagem e estabelece a obrigatoriedade do registro em todas as suas etapas.
Resolução COFEN nº 754 (COFEN, 2024b).	2024b	Nacional	Regulamenta o uso de prontuários eletrônicos e plataformas digitais, com requisitos de segurança, autenticidade e confidencialidade da informação.
Joint Commission International – Metas Internacionais de Segurança do Paciente (JCI) (JCI, 2024).	2024	Internacional	Associa a documentação clínica à comunicação eficaz, à transição do cuidado e à segurança do paciente.

Fonte: elaborado pela própria autora (2026).

A evolução normativa demonstra a ampliação das exigências relacionadas à formalização e à completude dos registros, bem como a inclusão de requisitos de segurança da informação, proteção de dados e rastreabilidade. Nesse contexto, a

documentação de enfermagem passa a integrar tanto o exercício profissional quanto as estratégias de segurança assistencial.

Essa regulamentação contempla os diferentes tipos de registros produzidos pela equipe de enfermagem, os quais se distinguem conforme as atribuições de cada categoria profissional. As Anotações de Enfermagem correspondem a registros descritivos realizados por técnicos, auxiliares e enfermeiros durante a execução das atividades assistenciais diretas, abrangendo observações clínicas, procedimentos executados e intercorrências (COFEN, 2023). De acordo com as Recomendações do COFEN para registros de enfermagem:

As Anotações de Enfermagem fornecem dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados/prescrição de enfermagem, suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente, resultados esperados e desenvolvimento da Evolução de Enfermagem (COFEN, 2023, p. 53).

A evolução de enfermagem, por sua vez, corresponde ao registro analítico e interpretativo que expressa julgamento clínico sobre o estado do paciente, as respostas às intervenções implementadas e a avaliação dos resultados alcançados (COFEN, 2016, 2023). Trata-se de atribuição privativa do enfermeiro, a quem compete igualmente a elaboração da prescrição de enfermagem, instrumento que estabelece o planejamento das intervenções e organiza o trabalho em equipe, enquanto técnicos e auxiliares participam da documentação por meio das anotações (COFEN, 2023, 2024a).

A equipe de enfermagem é responsável por aproximadamente 50% das informações registradas no prontuário do paciente (COFEN, 2016). Os técnicos de enfermagem, por atuarem diretamente na execução dos cuidados, produzem parte relevante desses registros, o que relaciona a qualidade de suas anotações à avaliação da assistência e à proteção legal da equipe.

No Brasil, a documentação de enfermagem é regulamentada por normas do COFEN que estabelecem requisitos éticos, técnicos e legais para os registros profissionais. Além dos requisitos formais de elaboração do registro, previstos no Código de Ética, como identificação do profissional, data e organização cronológica das anotações, as resoluções do conselho determinam a documentação de todas as etapas do PE (COFEN, 2016, 2017, 2023, 2024a).

As orientações nacionais apresentam correspondência com documentos internacionais que tratam da documentação como parte da comunicação profissional e da segurança do paciente. O Código de Ética do Conselho Internacional de Enfermagem - International Council of Nurses (ICN) - fundamenta essa exigência em princípios de confidencialidade e veracidade (ICN, 2021), enquanto a Associação Americana de Enfermagem - American Nurses Association (ANA) - descreve atributos operacionais dos registros, como clareza, completude e possibilidade de auditoria (ANA, 2010). A Comissão Conjunta Internacional - Joint Commission International (JCI) - também relaciona a qualidade do registro clínico à comunicação entre profissionais, à continuidade do cuidado e à redução de riscos assistenciais (JCI, 2024).

Consideradas em conjunto, essas orientações indicam que o registro das ações assistenciais integra o exercício profissional de enfermagem. No Brasil, essa exigência é organizada por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), metodologia que estrutura o processo de trabalho quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, possibilitando a produção da documentação clínica, conforme será discutido a seguir (COFEN, 2024a).

2.1.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem, Processo de Enfermagem e documentação

A SAE corresponde à organização do trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, criando condições para a operacionalização do cuidado. O PE consiste no método aplicado à assistência, estruturado em etapas interdependentes que orientam o raciocínio clínico e a tomada de decisão do enfermeiro. Embora relacionados, esses conceitos não são equivalentes: a SAE organiza o trabalho da enfermagem, enquanto o PE orienta a execução do cuidado direto ao paciente (Almeida *et al.*, 2023; COFEN, 2024a; Neves, 2020).

No Brasil, a consolidação da SAE está associada às contribuições de Wanda de Aguiar Horta que, na década de 1970, aplicou a Teoria das Necessidades Humanas Básicas à prática assistencial, organizando o cuidado em etapas articuladas e incorporando o registro como parte do processo assistencial (Horta, 1979). Essa organização do cuidado foi posteriormente incorporada às normativas profissionais, sendo atualmente referenciada na Resolução COFEN nº 736/2024, que define o Processo de Enfermagem como: “Um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do Enfermeiro direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado à pessoa, família, coletividade e grupos especiais” (COFEN, 2024a, p. 2).

Segundo Garcia e Nóbrega (2009), o PE corresponde a um modelo metodológico que permite aos profissionais identificar as necessidades de saúde de indivíduos, famílias e comunidades, considerando os diferentes momentos do ciclo vital e a presença de problemas reais ou potenciais. A partir dessa identificação, definem-se as necessidades que demandam intervenção profissional. No Brasil, a regulamentação estabelece que esse processo deve ser desenvolvido em todos os ambientes em que ocorre o cuidado de enfermagem, organizando-se em cinco etapas inter-relacionadas: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução de enfermagem (COFEN, 2024a).

A regulamentação profissional estabelece que técnicos e auxiliares participam do PE por meio das anotações de enfermagem, além da implementação e checagem dos cuidados prescritos, sob supervisão do enfermeiro (COFEN, 2024a, art. 7º). Essas

anotações devem registrar procedimentos executados, observações clínicas, intercorrências e respostas do paciente aos cuidados, fornecendo informações que apoiam o julgamento clínico e a tomada de decisão do enfermeiro nas etapas privativas do processo (COFEN, 2016; 2024a).

Embora técnicos e auxiliares não participem das etapas privativas de decisão diagnóstica ou prescrição no PE, estudos indicam que a compreensão desse processo por essa categoria profissional ainda é limitada em alguns cenários assistenciais, o que pode afetar a qualidade dos registros e a efetividade da assistência sistematizada (Guardia *et al.*, 2024). A Resolução COFEN nº 736/2024 estabelece que profissionais e instituições de saúde devem buscar meios para a capacitação e qualificação no uso do PE (COFEN, 2024a, art. 9º e 10º).

Na formação técnica, isso implica não apenas o ensino dos procedimentos de registro, mas também a compreensão de que as anotações integram o processo assistencial e influenciam suas diferentes etapas. A relação entre documentação e processo assistencial também se vincula à segurança do paciente, tema abordado na seção seguinte.

2.1.2 Registros de enfermagem, segurança do paciente e qualidade da assistência

A qualidade dos registros de enfermagem está relacionada à segurança do paciente, pois falhas na documentação podem comprometer a comunicação entre profissionais, a continuidade do cuidado e a identificação oportuna de alterações clínicas (Guardia *et al.*, 2024). O prontuário do paciente também constitui documento institucional utilizado em processos administrativos e judiciais, o que o torna relevante na apuração de responsabilidades profissionais e na análise da qualidade da assistência prestada (Millen, 2020; Silva; Dias, 2018).

Estudos baseados na análise de prontuários identificaram falhas formais recorrentes nos registros de enfermagem, como ilegibilidade, rasuras, uso de corretivo e ausência de data, horário e identificação profissional (Silva; Dias, 2018; Sulzbach *et al.*, 2022). Também foram descritas lacunas no conteúdo dos registros, com insuficiência de informações no histórico de enfermagem, especialmente em relação

a dados de anamnese, exame físico e aspectos psicossociais. Essas falhas são relatadas com maior frequência em setores de maior complexidade assistencial, como centro cirúrgico e unidades de terapia intensiva (Sulzbach *et al.*, 2022).

Alves *et al.* (2024) também registram a recorrência dessas inadequações na documentação de enfermagem, denominando - as como inconsistentes, ilegíveis e subjetivas, indicando que o problema não se limita a instituições específicas, mas aparece de forma mais ampla nos serviços de saúde.

Erros na assistência em saúde estão relacionados a falhas organizacionais e de comunicação nos serviços. Entre esses fatores estão registros incompletos ou inadequados, que podem comprometer a transmissão de informações entre profissionais, a continuidade do cuidado e a coordenação entre turnos e equipes. A presença de culturas organizacionais punitivas também favorece a subnotificação de eventos adversos, dificultando a identificação de riscos e a adoção de medidas voltadas à segurança assistencial (Duarte *et al.*, 2018).

O *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030* estabelece como objetivo estratégico fortalecer o fluxo contínuo de informação e conhecimento nos sistemas de saúde, com foco na redução de danos evitáveis e na melhoria da gestão de riscos. O documento enfatiza a importância de sistemas de notificação e de aprendizagem organizacional baseados na análise de prontuários e em outras fontes de informação assistencial (WHO, 2021).

Fragilidades na documentação de enfermagem também aparecem em processos de auditoria, nos quais falhas nos registros estão entre as principais causas de glosas hospitalares (Gonçalves; Banaszkeski, 2020; Santos *et al.*, 2025). Esse cenário indica que a qualidade da documentação não se limita à dimensão assistencial, pois influencia a avaliação institucional do cuidado e a sustentabilidade financeira dos serviços de saúde (Ceretta; Kinalski; Callegaro, 2023; Pertille; Ascari; Oliveira, 2018).

A qualidade dos registros de enfermagem também é influenciada pelas condições de trabalho nos serviços de saúde, como sobrecarga laboral, dimensionamento inadequado de pessoal e desconhecimento de aspectos legais da documentação (Bettanin; Rodrigues; Bacci, 2020; Rojas; Kehrig, 2023). Estudos indicam que intervenções educativas podem contribuir para a melhoria dos registros,

com avanços na organização das informações e na escrita profissional, embora ainda existam dificuldades para a manutenção dessas ações de forma contínua nos serviços (Linch *et al.*, 2017; Melo *et al.*, 2019). A Educação Permanente em Saúde (EPS), entendida como estratégia de qualificação dos processos de trabalho baseada na reflexão sobre as práticas cotidianas, é apontada como uma possibilidade para enfrentar essas dificuldades (Brasil, 2009).

As fragilidades descritas na literatura não aparecem apenas na prática assistencial, mas também nos processos formativos. Técnicos e auxiliares de enfermagem produzem grande parte dos registros presentes no prontuário, como discutido na seção 2.1. Por esse motivo, é necessário examinar como a formação de nível médio aborda essa dimensão do cuidado, tema tratado na seção seguinte.

2.2 FORMAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM

A formação de técnicos e auxiliares de enfermagem tem grande relevância na organização do sistema de saúde brasileiro, pois essa categoria representa mais de 60% dos profissionais com inscrição ativa no país, segundo dados do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem (COFEN, 2026). Para compreender esse processo formativo, é necessário examinar suas bases legais e as diretrizes que orientam a organização curricular, além de sua inserção na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, onde se situam os Institutos Federais, contexto institucional desta pesquisa.

2.2.1 Formação técnica em enfermagem no contexto brasileiro

A formação de técnicos em enfermagem insere-se no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, cuja organização é orientada pela Resolução CNE/CEB nº 6/2012. De acordo com essa normativa, essa modalidade educacional tem por finalidade: “Proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais” (Brasil, 2012, art. 5º).

No eixo tecnológico Ambiente e Saúde, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos descreve o perfil profissional do técnico em enfermagem, incluindo competências relacionadas à comunicação em saúde, ao trabalho em equipe multiprofissional e ao uso de tecnologias da informação e comunicação (Brasil, 2020). Entre essas atribuições estão atividades ligadas à produção e ao registro de informações no cuidado, aspecto relacionado à documentação assistencial no exercício profissional.

Os profissionais de nível médio em enfermagem, que incluem técnicos e auxiliares, representam a maior parte da força de trabalho da categoria no país. Dados do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem indicam que, em fevereiro de 2026, havia 1.904.000 técnicos e 268.522 auxiliares de enfermagem com inscrição ativa, totalizando 2.172.522 profissionais nessas categorias, de um total de 2.996.720 profissionais registrados (COFEN, 2026). Como esses profissionais participam diretamente da execução do cuidado e da produção de registros assistenciais no prontuário do paciente, torna-se necessário examinar a formação de nível médio em enfermagem e sua relação com a organização do cuidado nos serviços de saúde.

Adamy *et al.* (2023) analisam as Diretrizes Curriculares Nacionais da enfermagem como um contexto caracterizado por tensões regulatórias, fragilidades na interlocução institucional e desafios relacionados à qualidade e à regulação da oferta formativa. Essas características também aparecem na distribuição geográfica e no perfil dos cursos. Wermelinger *et al.* (2020), ao examinarem a formação técnica em enfermagem no país, identificaram a coexistência de desigualdades regionais marcadas pela concentração de cursos na região Sudeste e pela menor participação da região Norte. Os autores também apontam elevado grau de privatização da oferta e presença limitada da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica na formação técnica em enfermagem.

A presença limitada da Rede Federal na formação técnica em enfermagem contrasta com o papel atribuído aos Institutos Federais pela Lei nº 11.892/2008, que os define como instituições responsáveis pela oferta de educação profissional e tecnológica, com destaque para a formação técnica integrada e para a realização de pesquisa aplicada (Brasil, 2008).

Estudos sobre a educação profissional de nível médio em enfermagem ainda são pouco numerosos. Campos, Sciavon e Camargos (2018), ao analisar publicações entre 2001 e 2016, identificaram quantidade reduzida de pesquisas dedicadas ao tema, com predominância de estudos concentrados na região Sudeste. Os trabalhos examinados apontam desafios recorrentes na formação, como a predominância de práticas de caráter tecnicista, dificuldades na articulação entre teoria e prática e fragilidades na formação pedagógica dos docentes, além de problemas ligados às condições de trabalho e à infraestrutura dos cursos.

A documentação assistencial integra as atribuições profissionais do técnico em enfermagem, e a literatura descreve fragilidades mais amplas no processo formativo dessa categoria. Entretanto, os estudos examinados não identificam investigações específicas sobre o ensino das anotações de enfermagem nos cursos técnicos. Essa ausência de estudos indica a necessidade de analisar como essa competência tem sido abordada na formação profissional de nível médio.

2.2.2 Ensino das anotações de enfermagem e estratégias pedagógicas na formação técnica

As anotações de enfermagem, apresentadas na seção 2.1, fazem parte do cuidado e integram o exercício profissional. Apesar do reconhecimento normativo dessa atividade, dificuldades ainda são observadas na prática assistencial, especialmente quanto ao domínio das normas e à compreensão das implicações ético-legais associadas a registros incompletos ou inadequados. Pesquisas realizadas com equipes de enfermagem apontam a presença dessas dificuldades no cotidiano dos serviços (Borges *et al.*, 2017).

As inadequações nos registros observadas no exercício profissional também aparecem no processo formativo. Estudos indicam que, diante das demandas imediatas do cuidado, muitos profissionais priorizam a execução da assistência e deixam o registro das ações realizadas para um momento posterior. Essa situação é sintetizada no relato: "[...] você não vai deixar de fazer assistência para poder registrar o que você está fazendo" (Barreto *et al.*, 2019, p. 4). Essa realidade ganha maior importância quando se considera que aproximadamente metade das informações

registradas no prontuário do paciente é produzida pela equipe de enfermagem (Alves *et al.*, 2024), o que evidencia a relevância da comunicação escrita na organização do cuidado.

Estudos sobre a formação profissional de nível médio em enfermagem apontam desafios relacionados à articulação entre teoria e prática, à formação pedagógica dos docentes e às condições institucionais que influenciam o processo educativo. Fioramonte, Marin e Pinto (2022), ao analisarem pesquisas publicadas entre 2012 e 2020, identificaram iniciativas que buscam ampliar a participação dos estudantes no processo de aprendizagem. Os autores também registram dificuldades na superação da dicotomia entre teoria e prática e na implementação de metodologias ativas de ensino, associadas a limitações formativas e institucionais.

Iniciativas educativas voltadas à documentação assistencial têm sido relacionadas à melhoria dos registros de enfermagem, embora as inadequações não sejam totalmente eliminadas. Experiências de ensino sobre anotações de enfermagem, desenvolvidas com estudantes e profissionais, indicam que os participantes reconhecem a importância dos registros e que ações educativas junto às equipes assistenciais contribuem para discutir a prática e aprimorar a documentação. Ainda assim, revisões da literatura apontam que estudos dedicados ao ensino das anotações de enfermagem nos cursos técnicos são pouco numerosos (Camargo; Pereira, 2017; Gonçalves *et al.*, 2024; Silva; Dias, 2018).

Pesquisas sobre o ensino de enfermagem apontam diferentes estratégias pedagógicas utilizadas na formação técnica. Fontana, Wachekowski e Barbosa (2020), em estudo com estudantes, identificaram que atividades práticas realizadas em campo de estágio e em laboratório favorecem a aprendizagem. Estudos sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em atividades remotas também indicam maior interação e dinamismo no processo de ensino-aprendizagem, embora sejam relatadas limitações relacionadas à acessibilidade (Florêncio; Melo; Mercado, 2024). Pesquisas sobre simulação clínica mostram que essa estratégia pode ser incorporada à formação quando apoiada por projetos pedagógicos estruturados e por suporte institucional adequado (Mazzo *et al.*, 2025).

A formação pedagógica dos docentes constitui tema recorrente nos estudos sobre educação profissional técnica em enfermagem. Góis, Azevedo e Rodrigues,

(2022) em investigação realizada com enfermeiros atuantes na docência, descreveram que uma experiência formativa baseada na problematização possibilita ao docente ressignificar sua prática. Ludugério *et al.* (2024) destacam que a docência nesse campo exige o desenvolvimento de competências pedagógicas específicas e atualização profissional contínua. Embora esses estudos não tratem diretamente do ensino das anotações de enfermagem, as estratégias descritas contribuem para a discussão sobre a qualificação da documentação assistencial, especialmente quando envolvem situações práticas, reflexão orientada e organização sistemática dos conteúdos.

2.2.3 Institutos Federais e produção de materiais

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, como instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, voltadas à oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino (Brasil, 2008, art. 2º). Entre seus objetivos estão a oferta de educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, e a realização de pesquisas aplicadas voltadas ao desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e à ampliação de seus benefícios para a comunidade (Brasil, 2008, art. 7º, incisos I e III). Essa estrutura articula ensino, pesquisa e extensão de acordo com as realidades regionais e as demandas do mundo do trabalho, diferenciando-se de modelos formativos orientados exclusivamente por interesses de mercado (Pacheco, 2011).

A produção de materiais educacionais nos Institutos Federais está relacionada à articulação entre ensino, pesquisa e extensão e às demandas formativas identificadas no cotidiano institucional. Rocha e Prado (2025) e Amadei (2024) destacam que o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) reforça esse processo ao exigir, como requisito para titulação, a elaboração de um produto educacional vinculado ao contexto investigado.

Rocha e Prado (2025), ao analisar dissertações do ProfEPT relacionadas ao ensino técnico em enfermagem, identificaram a produção de cartilhas, manuais, documentários e ambientes virtuais de aprendizagem elaborados a partir de

demandas observadas nas instituições formadoras e nos serviços de saúde. Segundo os autores, esses produtos articulam referências teóricas e experiência docente e são submetidos a processos de validação junto ao público-alvo. Essa produção integra a perspectiva da pesquisa aplicada à educação profissional, voltada à sistematização de práticas pedagógicas e ao atendimento de necessidades formativas presentes no cotidiano institucional.

A produção de materiais educacionais nesse contexto também se relaciona às transformações tecnológicas que têm impactado os processos de documentação em saúde. A incorporação de sistemas informatizados e o desenvolvimento de recursos educacionais digitais influenciam tanto a prática assistencial quanto a formação profissional. Quando integradas a propostas pedagógicas estruturadas, essas tecnologias podem contribuir para a qualificação do registro de enfermagem (Linch *et al* , 2017).

2.2.4 O Instituto Federal do Paraná e o Curso Técnico em Enfermagem

O IFPR, integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é uma instituição multicampi e descentralizada que oferece educação profissional e tecnológica articulada à pesquisa aplicada e às atividades de extensão.

O Curso Técnico em Enfermagem do Campus Curitiba tem origem em 1992, quando foi criado na Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. Em 2010, passou a integrar o IFPR por meio da Resolução CONSUP nº 39/2010. Em 2023, o curso passou por atualização curricular, em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 1/2021 e com a 4ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (Brasil, 2020, 2021; IFPR, 2010).

O curso é oferecido na modalidade subsequente ao ensino médio, com carga horária total de 1.600 horas, distribuídas em 1.200 horas de componentes teórico-práticos e 400 horas de Prática Profissional Supervisionada. A organização curricular em módulos permite certificação intermediária como Auxiliar de Enfermagem após a conclusão de 1.200 horas e habilitação como Técnico em Enfermagem ao final das 1.600 horas (IFPR, 2023).

A matriz curricular é organizada em módulos que incluem fundamentos teóricos, práticas clínico-assistenciais, saúde coletiva e componentes transversais. A temática das anotações de enfermagem é introduzida na disciplina Fundamentos de Enfermagem (100 horas) e retomada nos módulos seguintes, como Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Saúde da Mulher, Pediatria, Urgência e Emergência, Terapia Intensiva e Saúde Mental. Essa aprendizagem é aprofundada durante a Prática Profissional Supervisionada, etapa em que os estudantes utilizam os conhecimentos adquiridos em situações reais de cuidado.

O IFPR Campus Curitiba possui convênios com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Paraná, além de hospitais privados e filantrópicos, o que possibilita a realização de estágios em diferentes cenários assistenciais. Esses campos de prática incluem serviços que utilizam prontuários físicos e instituições que adotam sistemas informatizados, permitindo que os estudantes tenham contato com diferentes formas de documentação clínica.

O corpo docente é composto por enfermeiros especialistas, mestres e doutores, que atuam predominantemente em regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva. Além das atividades de ensino, são realizadas reuniões periódicas de colegiado para discussão de casos, acompanhamento de egressos e ajustes curriculares.

Embora a organização curricular inclua a temática da documentação de enfermagem ao longo do curso, ainda há a necessidade de compreender como o ensino das anotações ocorre na formação técnica.

2.3 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA DOCUMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM

A qualificação do ensino da documentação de enfermagem relaciona-se ao uso de tecnologias que apoiam tanto a prática profissional quanto os processos formativos. Essas tecnologias abrangem desde sistemas informatizados de registro até recursos pedagógicos voltados à aprendizagem, configurando instrumentos que contribuem para o ensino e para o exercício profissional qualificado.

2.3.1 Prontuário eletrônico

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é uma tecnologia digital utilizada para a documentação clínica e o registro de informações em saúde, incluindo aquelas produzidas pela equipe de enfermagem. Dutra, Silva e Araujo (2020), em revisão integrativa, identificaram que seu uso é associado a aspectos éticos e legais do registro, à segurança da informação, à integração de dados assistenciais e ao suporte a auditorias e pesquisas. Os autores destacam, entretanto, que essas evidências não demonstram relação causal direta entre a adoção do PEP e o aumento da qualidade ou da produtividade dos serviços de saúde.

Ávila *et al.* (2022) descrevem o prontuário eletrônico como um recurso que favorece a integração das informações e o acompanhamento longitudinal dos usuários, especialmente no trabalho em equipes multiprofissionais. Entretanto, sua efetividade depende de condições organizacionais e formativas, como a padronização dos registros, a interoperabilidade entre sistemas e a capacitação dos profissionais para o uso adequado da tecnologia.

A Resolução COFEN nº 754/2024 regulamenta o uso de prontuários eletrônicos e plataformas digitais na enfermagem. Entre suas determinações estão a identificação do profissional por certificação digital ou login individual, a confidencialidade das informações com acesso restrito e a segurança no processo de assinatura digital. Essas diretrizes dialogam com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Lei nº 13.709/2018), que estabelece princípios como finalidade, minimização e consentimento para o tratamento de dados pessoais. Além disso, a Lei nº 13.787/2018 assegura que documentos digitalizados possuem o mesmo valor probatório que os documentos originais (Brasil, 2018a, 2018b; COFEN, 2024b).

A implementação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) na Atenção Primária à Saúde apresentou crescimento no período recente, passando de 8.930 unidades de saúde em 2017 para 26.091 em 2022 (Celuppi *et al.*, 2024). Profissionais de enfermagem reconhecem essa ferramenta como um recurso que contribui para a organização do cuidado; entretanto, persistem desafios relacionados à usabilidade, à

adaptação dos fluxos de trabalho e à integração entre sistemas de informação (Cabral *et al.*, 2024).

Os sistemas eletrônicos ampliam a capacidade de armazenamento, rastreabilidade e recuperação das informações, mas sua adoção isolada não garante a qualidade da documentação. A produção dos registros continua dependente do julgamento clínico, da clareza da comunicação escrita e do conhecimento das normativas profissionais. Quando utilizados sem formação adequada, esses sistemas podem favorecer registros mecanizados ou excessivamente padronizados, o que pode reduzir o caráter analítico da documentação (Cercilier *et al.*, 2021; Guardia *et al.*, 2024; Oliveira *et al.*, 2016).

Estudos indicam que as fragilidades na documentação de enfermagem coexistem com desafios institucionais e pedagógicos, o que reforça a necessidade de instrumentos educacionais contextualizados (Barreto *et al.*, 2019; Ludugério *et al.*, 2024; Pertille; Ascari; Oliveira, 2018). Nesse contexto, a elaboração de materiais educativos no âmbito da educação profissional pode contribuir para enfrentar essas dificuldades. Manuais e guias, quando fundamentados teoricamente e submetidos a processos de validação metodológica, constituem tecnologias educacionais que podem auxiliar na sistematização de orientações sobre a documentação de enfermagem (Amadei, 2024; Rocha; Prado, 2025; Silva; Fritzen; Linch, 2023).

2.3.2 Manuais como tecnologias educacionais na formação profissional

Manuais e guias educativos são tecnologias educacionais estruturadas, destinadas a orientar condutas e apoiar decisões clínicas por meio da organização sistemática de saberes, normas e protocolos. Marcatto *et al.* (2024, p. 2) definem esses materiais como uma “[...] tecnologia leve-dura¹ capaz de favorecer decisões clínicas e orientar condutas através da estruturação de saberes, normas e protocolos”,

¹O conceito de tecnologia leve-dura integra a classificação proposta por Merhy (2002), que distingue tecnologias duras (equipamentos e instrumentos), leve-duras (saberes estruturados, normas e protocolos) e leves (relações interpessoais no cuidado). Manuais e guias educativos enquadram-se nessa categoria por organizarem conhecimentos técnico-científicos em formato sistematizado.

ressaltando sua função mediadora entre o conhecimento técnico-científico e a prática profissional.

Além de instrumentos de consulta, esses materiais também desempenham função pedagógica ao favorecer a transferência do conhecimento e aproximar referenciais teóricos da realidade dos serviços de saúde (Neves, 2020). Essa característica os diferencia de conteúdos meramente informativos, pois sua elaboração exige fundamentação teórica explícita, organização didática coerente e objetivos formativos definidos.

A incorporação de tecnologias educacionais na formação profissional envolve mudanças nas práticas de ensino. Perrenoud (2000, p. 171) afirma que a centralidade do processo formativo deve deslocar-se do ensino para as aprendizagens, destacando que “[...] o paradigma visado não diz respeito como tal às tecnologias. Concerne às aprendizagens”. Nesse sentido, o manual educativo não substitui o processo pedagógico, mas pode atuar como recurso de apoio, ao favorecer que o estudante relacione novos conteúdos aos conhecimentos já adquiridos (Almeida *et al.*, 2023).

Na formação técnica em enfermagem, a produção de cartilhas e manuais é uma estratégia relacionada à educação profissional voltada às demandas do trabalho e do Sistema Único de Saúde. Rocha e Prado (2025) identificaram que dissertações do ProfEPT têm resultado em materiais educacionais elaborados a partir de demandas formativas concretas, reunindo fundamentação teórica, experiência docente e processos de validação junto ao público-alvo. Freitas (2024) acrescenta que esses materiais contribuem para a integração entre conhecimentos teóricos e prática assistencial.

No campo da pesquisa aplicada à educação profissional, a elaboração de manuais exige procedimentos metodológicos definidos. Vilarinho (2024) destaca a importância da validação científica para garantir que o material produzido seja válido e confiável, evitando a circulação de conteúdos descontextualizados ou metodologicamente frágeis. Marcatto *et al.* (2024) descrevem processos que incluem fundamentação teórica, levantamento bibliográfico, definição de objetivos educacionais, avaliação por especialistas e análise da adequação pedagógica. A participação do público-alvo nas etapas iniciais de construção também permite

identificar necessidades formativas específicas e ajustar o conteúdo às demandas reais dos participantes (Marcatto *et al.*, 2024).

Na documentação de enfermagem, cuja produção envolve requisitos técnicos, normativos e ético-legais, a sistematização de orientações em um manual pode contribuir para organizar critérios de registro, padronizar a linguagem profissional e explicitar responsabilidades entre os membros da equipe. Parte-se da compreensão de que tecnologias educacionais podem apoiar processos formativos quando articuladas a estratégias pedagógicas consistentes (Espadaro, 2023; Rocha; Prado, 2025; Silva; Fritzen; Linch, 2023).

O manual educativo, concebido como produto educacional fundamentado teoricamente e alinhado às normativas profissionais, constitui um recurso pedagógico compatível com as exigências da formação técnica em enfermagem. Com base nesse referencial, definiu-se o percurso metodológico utilizado para examinar as práticas docentes e orientar a elaboração do manual.

3 METODOLOGIA

A seguir são descritos os procedimentos metodológicos que orientaram o desenvolvimento do estudo.

3.1 TIPO DE ESTUDO E DESENHO METODOLÓGICO

Trata-se de pesquisa qualitativa, de natureza metodológica, com caráter exploratório e descritivo, conforme as definições apresentadas por Canzonieri (2010) e Minayo (2015). A abordagem qualitativa é descrita na literatura como aquela voltada à análise de práticas sociais e profissionais, considerando os significados atribuídos pelos sujeitos em contextos históricos e institucionais específicos (Godoy, 1995; Minayo, 2015).

As pesquisas exploratórias e descritivas são caracterizadas por Canzonieri (2010) como estudos que articulam revisão bibliográfica, produção de dados empíricos e análise interpretativa, com a finalidade de explicitar problemas relacionados ao objeto investigado e ampliar sua compreensão.

O percurso metodológico foi estruturado em quatro etapas articuladas. Inicialmente, realizou-se revisão narrativa da literatura científica e das normativas profissionais relacionadas à documentação clínica, à Sistematização da Assistência de Enfermagem e à educação profissional. Em seguida, procedeu-se à produção de dados por meio de grupo focal com docentes enfermeiros do curso técnico em enfermagem. O material empírico foi posteriormente analisado à luz da Análise do Discurso Francesa, na perspectiva de Eni Orlandi (Orlandi, 2001). Por fim, realizou-se a triangulação das evidências, articulando dados empíricos, referenciais teóricos e normativos, com o objetivo de subsidiar a definição do conteúdo, da linguagem e da estrutura do manual proposto como produto educacional.

A articulação entre essas etapas configura procedimento de triangulação de dados, compreendida como estratégia de rigor que combina múltiplas fontes de evidência empíricas, documentais e bibliográficas com o objetivo de ampliar a consistência interpretativa e a validade dos achados (Minayo, 2015).

3.2 CENÁRIO E PARTICIPANTES

A pesquisa foi desenvolvida no Curso Técnico em Enfermagem do IFPR, Campus Curitiba. O curso é ofertado na modalidade subsequente ao ensino médio, com carga horária total de 1.600 horas, distribuídas ao longo de dois anos letivos, incluindo 400 horas de Prática Profissional Supervisionada obrigatória. A organização curricular é modular, permitindo certificação intermediária como Auxiliar de Enfermagem após a integralização dos módulos iniciais e habilitação como Técnico em Enfermagem mediante a conclusão dos módulos finais (IFPR, 2023).

A escolha do cenário relaciona-se à inserção institucional da pesquisadora no curso, o que possibilitou acesso ao campo e conhecimento prévio do contexto formativo, além de dialogar com as especificidades dos Institutos Federais, caracterizados pela articulação entre educação profissional, infraestrutura laboratorial e formação técnica fundamentada em bases científicas e pedagógicas.

Participaram do estudo oito docentes enfermeiros atuantes no curso, selecionados por amostragem intencional, considerando sua vinculação direta com o ensino da documentação clínica e do Processo de Enfermagem. Adicionalmente, um nono docente contribuiu por meio de relato individual gravado em áudio, posteriormente incorporado ao corpus analítico como registro complementar.

Os critérios de inclusão foram: ser enfermeiro com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem; atuar como docente no curso técnico; e ministrar componentes curriculares relacionados à documentação clínica ou ao Processo de Enfermagem. Foram excluídos docentes afastados ou impossibilitados de participar do grupo focal no período da coleta. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).

3.3 PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A produção de dados ocorreu por meio de grupo focal realizado em novembro de 2025, com duração de uma hora e vinte e cinco minutos. O encontro seguiu roteiro semiestruturado (Apêndice B), contemplando questões relacionadas às práticas docentes no ensino da documentação de enfermagem, às dificuldades observadas no

processo formativo e às sugestões voltadas à qualificação do ensino. As falas foram gravadas em áudio, mediante autorização prévia dos participantes, formalizada por meio de Termo de Cessão de Direito de Uso de Voz (Anexo D), e posteriormente transcritas na íntegra para fins de análise.

A escolha do grupo focal fundamentou-se em sua caracterização como técnica qualitativa centrada na discussão coletiva. Conforme descrevem Pope e Mays (2009), essa modalidade de entrevista privilegia a interação entre os participantes, possibilitando acessar percepções, experiências e posicionamentos que emergem no próprio processo de interlocução, e não apenas em relatos individuais isolados.

A análise do material empírico foi conduzida à luz da Análise do Discurso de linha francesa, na perspectiva teórico-metodológica proposta por Eni Orlandi, conforme sistematizada por Orlandi (2001), Caregnato e Mutti (2006) e Macedo *et al.* (2008). Nessa abordagem, o discurso é compreendido como produção de sentidos historicamente situada, atravessada por condições sociais, ideológicas e institucionais. A linguagem, portanto, não é tomada como instrumento neutro de comunicação, mas como espaço de constituição de significados e de posições discursivas.

O corpus analítico foi constituído pelas transcrições integrais do grupo focal. O material foi submetido a leituras sucessivas e analíticas, com o objetivo de identificar regularidades, deslocamentos e recorrências nos enunciados. A partir desse movimento, foram delimitadas unidades de sentido relacionadas às práticas docentes, às concepções sobre o ensino dos registros de enfermagem e às demandas formativas expressas pelos participantes. Essas unidades foram agrupadas em eixos discursivos, que subsidiaram a construção das categorias analíticas. A etapa interpretativa articulou os sentidos produzidos no discurso ao referencial teórico adotado e às condições institucionais do curso investigado.

A saturação teórica foi considerada quando a análise passou a indicar recorrência de sentidos e ausência de novos elementos discursivos relevantes para aprofundar a compreensão do fenômeno, conforme o critério descrito por Fontanella *et al.* (2011).

3.4 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 89107925.5.0000.5347; Parecer nº 7.701.043) e do Instituto Federal do Paraná (CAAE nº 89107925.5.3001.8156; Parecer nº 7.848.005), em conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012 e nº 510/2016. Os pareceres consubstanciados encontram-se no Anexo B.

Antes da produção dos dados, todos os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos, procedimentos, potenciais riscos e benefícios da pesquisa. A concordância foi formalizada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e do Termo de Cessão de Direito de Uso de Voz (Anexo D).

O anonimato foi garantido por meio da codificação alfanumérica das falas (P1 a P9) e pela retirada de informações que pudessem possibilitar identificação direta ou indireta. Os registros de áudio foram armazenados em ambiente digital protegido, com acesso restrito à pesquisadora e à orientadora, e permanecerão sob guarda pelo período de cinco anos, conforme disposto na Resolução CNS nº 510/2016 (art. 28, inciso IV), sendo posteriormente descartados de forma segura. Os dados produzidos foram utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

A aplicação desse percurso metodológico possibilitou a produção de material empírico cuja análise é apresentada a seguir.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos são apresentados e discutidos a partir das categorias temáticas emergidas na análise dos dados, articuladas ao referencial teórico e às normativas profissionais que orientam a documentação clínica em enfermagem.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

O grupo focal foi realizado nas dependências do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, com duração aproximada de uma hora e vinte e cinco minutos. Participaram da sessão oito docentes enfermeiros vinculados ao Curso Técnico em Enfermagem, com atuação no ensino teórico, em práticas laboratoriais, em atividades de simulação clínica e na supervisão de estágios curriculares.

Além do grupo focal, um nono docente contribuiu com a pesquisa por meio de relato individual gravado em áudio e enviado previamente, conforme autorização expressa no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Considerando que essa participação não ocorreu em contexto interacional, o material foi tratado como registro de diário de campo e utilizado apenas de forma complementar, não integrando a análise das interações discursivas do grupo focal.

Para garantir o anonimato, os participantes foram identificados por códigos alfanuméricos de P1 a P8. O relato individual foi identificado como P9, exclusivamente para fins de organização do material empírico. O Quadro 2 apresenta a caracterização dos participantes quanto ao tempo de experiência no ensino técnico em enfermagem e ao contexto institucional de atuação.

Quadro 2 – Caracterização dos participantes do grupo focal

Código	Tempo de experiência no ensino técnico	Contexto de atuação Institucional
P1	18 anos	16 anos IFPR + 2 anos instituição privada

Código	Tempo de experiência no ensino técnico	Contexto de atuação Institucional
P2	6,5 anos	4 anos IFPR + 2,5 anos instituições privadas
P3	17 anos	13 anos IFPR + 4 anos instituições privadas
P4	17 anos	17 anos IFPR
P5	13 anos	13 anos IFPR
P6	2,8 anos	1 ano instituição privada + 1,8 anos IFPR
P7	9 anos	9 anos IFPR
P8	3 anos	3 anos IFPR
P9	18 anos	8 anos IFPR

Fonte: elaborado pela própria autora (2026).

Entre os docentes participantes do grupo focal, o tempo de experiência no ensino técnico variou de 2,8 a 18 anos. Todos relataram atuação no Instituto Federal do Paraná, sendo que quatro deles também mencionaram experiência docente em instituições privadas.

A análise do discurso, fundamentada no referencial de Orlandi (2001), permitiu identificar regularidades de sentido nas falas dos participantes. A partir dessas regularidades, foram delineados três eixos temáticos, compreendidos como gestos de interpretação sobre o corpus empírico, em consonância com os pressupostos da Análise do Discurso. Esses eixos emergem do material produzido no grupo focal e se relacionam com os tópicos orientadores do roteiro, preservando a singularidade das falas e os efeitos de sentido produzidos na interação discursiva.

O Quadro 3 apresenta a síntese das categorias analíticas e das respectivas subcategorias identificadas ao longo do processo de interpretação.

Quadro 3 – Síntese das categorias temáticas emergentes da análise do discurso

Categoria temática	Subcategorias identificadas
Organização do ensino: estrutura curricular, fluxo e protocolos	• Disciplina de Fundamentos de Enfermagem como alicerce inicial • Método SOAP (subjetivo, objetivo, avaliação e plano) e recomendações COFEN • Longitudinalidade e especificidades por área clínica • Estágios supervisionados e práticas simuladas • Cultura colegiada e ajustes pedagógicos
Dificuldades, desafios e problemas percebidos no ensino-aprendizagem	• Déficits de formação básica • Domínio insuficiente de terminologia técnica • Fragilidades no raciocínio clínico e automatismo documental • Insegurança e lentidão na execução e dificuldades na gestão do tempo
Proposições para materiais didáticos, metodologias e recursos pedagógicos	• Materiais adaptados ao nível técnico • Tecnologias digitais, gamificação e inteligência artificial • Metodologia das quatro perguntas • Simulação e casos clínicos • Análise de erros e exemplos reais

Fonte: elaborado pela própria autora (2026).

As seções seguintes apresentam os resultados organizados a partir dessas categorias e, em momento subsequente, realizam a discussão à luz do referencial teórico adotado.

4.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: ENTRE PROGRESSÃO E FRAGMENTAÇÃO

O ensino das anotações foi descrito como um percurso distribuído ao longo do curso, iniciado na disciplina de Fundamentos de Enfermagem e retomado nos componentes curriculares subsequentes até os estágios supervisionados. P4 identificou Fundamentos como o primeiro contato do estudante com a anotação, momento em que é apresentada a construção de uma anotação básica. P2

acrescentou que o tema não se restringe às aulas teóricas, sendo também trabalhado nas práticas de laboratório e nos estágios hospitalares. Isso indica que o ensino do registro atravessa diferentes componentes curriculares e espaços de formação, sem se limitar a um momento isolado do curso.

Essa progressão aproxima-se da proposta apresentada por Neves (2020), que defendem um currículo integrado no qual o conhecimento é retomado de forma progressiva ao longo da formação. Nesse modelo, os conteúdos são distribuídos entre os módulos de acordo com o avanço do estudante, favorecendo a aplicação gradual do Processo de Enfermagem em contextos assistenciais de maior complexidade.

Em relação ao conteúdo trabalhado com os estudantes, os participantes mencionaram a utilização de orientações normativas como referência para o ensino. P4 afirmou que a orientação adotada segue o que é recomendado pelo COFEN, sendo o método SOC² (subjetivo, objetivo e conduta) citado como parâmetro para a organização dos registros. A esse respeito, P7 relatou:

“[...] entra um pouquinho no processo de enfermagem também, e o SOC, que é dados subjetivos, objetivos e as condutas, sempre no final da disciplina de Fundamentos, porque eles precisam já ter todo um conhecimento de técnicas e procedimentos pra colocar nas condutas, também de exame físico, de toda a avaliação do paciente. [...] E daí lá no final a gente constrói”.

Nas demais disciplinas, o tema é retomado com conteúdo específicos de cada área. P8 afirmou que o estudante chega às etapas seguintes com uma “estrutura” construída inicialmente e, de forma progressiva, passa a utilizar terminologia técnica própria dos diferentes campos assistenciais. Esse processo indica a construção gradual de uma base organizadora que se amplia à medida que as situações de cuidado se tornam mais complexas.

Além das características específicas de cada disciplina, os participantes também relataram ajustes nos registros decorrentes de exigências dos serviços de

²Essa abordagem, denominada pelos docentes como SOC (Subjetivo, Objetivo, Conduta), propõe uma sequência que parte da condição do paciente, percorre a intervenção realizada e conclui com o resultado observado, aproximando-se da lógica do método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano).

saúde. P1 mencionou que, em determinados cenários, alguns termos ou formas de registro são solicitados por motivos administrativos, como o faturamento, influenciando diretamente a maneira como as anotações são realizadas. Esse relato indica que o ensino do registro não ocorre de forma isolada, mas em diálogo com as dinâmicas institucionais dos campos de prática.

A dimensão ético-legal foi mencionada como um elemento relevante para a ênfase na qualidade das anotações. P4 destacou que a anotação “[...] *tem esse papel de respaldar a nossa conduta, de pontuar qual o cuidado que a gente fez e qual o resultado que a gente teve [...] é um respaldo legal*”. P7 expressou entendimento semelhante ao afirmar que “[...] *o que não foi escrito não foi realizado*”, atribuindo ao registro a função de comprovar a assistência prestada. Essas percepções se relacionam com as exigências institucionais, administrativas e legais discutidas na seção 2.1.2, que influenciam a forma como a documentação é produzida nos campos de prática.

O tempo dedicado ao ensino das anotações também foi mencionado pelos participantes. P7 observou que, na disciplina de Fundamentos de Enfermagem, o conteúdo teórico ocupa um número reduzido de encontros, correspondendo a três aulas de 50 minutos. Os demais participantes ressaltaram que o contato com o tema se estende às práticas de laboratório, às simulações e aos estágios supervisionados que, segundo P2, totalizam 400 horas e aproximadamente 40 dias de atividades práticas no terceiro semestre, momento em que o registro passa a ser exigido nos estágios.

A qualidade da documentação não resulta apenas da repetição do conteúdo ao longo dos módulos, mas da forma como ele é desenvolvido de maneira articulada e progressiva. A fragmentação entre componentes curriculares pode comprometer a consolidação de competências transversais. Nesse contexto, fragilidades nos registros costumam estar associadas à compreensão limitada de seu papel no processo de cuidado, sendo frequentemente percebidos como uma exigência burocrática. Estudos indicam que inconsistências documentais persistem mesmo em contextos normativamente estruturados, o que reforça a necessidade de mediação pedagógica contínua para integrar normas, linguagem técnica e tomada de decisão clínica (Adamy *et al.*, 2023; Azevedo; Cruz, 2021; Barreto *et al.*, 2019).

A construção de casos clínicos por meio de simulação foi mencionada como estratégia preparatória antes da inserção nos campos de prática. P4 descreveu atividades realizadas com manequins e dispositivos, nas quais os estudantes são orientados a descrever o caso e elaborar o registro correspondente. P8 acrescentou que, nessas situações, o estudante recebe prontuário, prescrição e descrição clínica para análise. P7, contudo, observou que alguns alunos tendem a reproduzir modelos de registro de forma repetitiva, mesmo quando não correspondem ao caso apresentado, o que evidencia limites da estratégia quando não há problematização sistemática.

Além das estratégias didáticas, a organização institucional também foi mencionada como um elemento que influencia o ensino. No contexto do IFPR, P1 relatou a realização de reuniões mensais do colegiado, enquanto P3 destacou que os mesmos docentes acompanham as atividades teóricas e os estágios, favorecendo a continuidade pedagógica. Esses arranjos destacam a importância da participação docente na gestão do projeto pedagógico e da articulação entre diferentes atores institucionais como condições para uma formação de qualidade (Adamy *et al.*, 2023; Franco; Fernandes; Millão, 2020).

A análise indica que o currículo organiza o ensino das anotações como um percurso progressivo, retomado em diferentes momentos da formação e em distintos contextos de prática. Entretanto, a efetivação dessa progressão depende da articulação entre disciplinas, da mediação docente e das demandas institucionais presentes nos campos de estágio. Nesse contexto, emergem tensões entre propostas de integração curricular e processos de fragmentação que atravessam o ensino do registro ao longo da formação.

4.3 DIFICULDADES DISCENTES: DÉFICITS DE BASE E DESAFIOS COGNITIVOS

Os docentes relataram dificuldades recorrentes dos estudantes relacionadas à escrita, à leitura e ao uso da linguagem nos registros de enfermagem. Segundo os participantes, essas limitações não se restringem ao emprego de termos técnicos, mas envolvem também a elaboração do texto e a organização das informações registradas. Tais fragilidades, observadas nas atividades teóricas, nas práticas e nos estágios, influenciam a forma como as anotações são produzidas, como ilustra P1: *“Tem muito erro ortográfico, muita letra ilegível, que a gente tem que estar sempre trabalhando”*.

Esses relatos se aproximam do que Góis, Azevedo e Rodrigues (2022, p. 1) descrevem como “deficiência educacional prévia”. Os autores identificaram entre discentes, limitações na fala e na escrita da língua portuguesa, além de dificuldades de interpretação que dificultam o acompanhamento do vocabulário e das demandas linguísticas próprias da área da saúde. Essa fragilidade em conteúdos básicos também é apontada por Campos, Sciavon e Camargos (2018), que associam o desempenho insatisfatório em disciplinas específicas da enfermagem a lacunas provenientes do ensino fundamental e médio. Melaragno *et al.* (2023) acrescentam que a educação formal frequentemente se apresenta de forma desigual, produzindo lacunas formativas que a formação inicial em enfermagem nem sempre consegue suprir.

Os déficits de base se manifestam de forma mais evidente quando associados ao domínio da terminologia técnica. P3 exemplificou que, ao passar pela Clínica Médica ou pela Clínica Cirúrgica, disciplinas que empregam vocabulário mais específico, os registros se tornam “mais falhos”, sobretudo na descrição de dispositivos, fluidos e localizações anatômicas. Dodo *et al.* (2020) indicam que o uso inadequado de termos técnicos constitui falha recorrente na documentação de enfermagem, podendo comprometer a clareza das informações e a compreensão da situação clínica registrada. Esse achado sinaliza a necessidade de estratégias formativas voltadas ao domínio progressivo da linguagem própria da área.

Como estratégias de enfrentamento dessas deficiências, os docentes relataram o uso de correções diretas e orientações reiteradas durante práticas e estágios. P1 exemplificou essa condução ao relatar:

“Por exemplo, vou sinalizando: ‘torácico’ eles escrevem com X normalmente. Aí eu digo: você vai escrever essa palavra pra sempre, então faz assim: chega em casa e escreve diversas vezes até você lembrar que ela é com C. Você vai tentando ali e vai ajudando”.

Além das lacunas formativas prévias, há uma tensão entre o domínio técnico e a integração entre teoria e prática no ensino, o que dificulta o desenvolvimento do raciocínio clínico necessário para a documentação. Neves (2020) argumenta que, quando a formação privilegia o “saber fazer” mecânico em detrimento da reflexão, o registro de enfermagem tende a assumir caráter instrumental, transformando-se em atividade automatizada voltada ao preenchimento de formulários.

Embora o uso de formulários e modelos estruturados contribua para a organização dos dados em cenários de ensino, o preenchimento passivo dessas estruturas pode mecanizar o registro e produzir anotações superficiais, desvinculadas da análise clínica (Guardia *et al.*, 2024; Neves, 2020). Esse processo aproxima-se do que Sulzbach *et al.* (2022, p. 15) descrevem como prática repetitiva marcada pelo fenômeno do “cópia e cola”, em que informações são reproduzidas nos prontuários sem análise individualizada da evolução do paciente, o que pode comprometer a segurança do paciente e reduzir a contribuição do registro para a qualificação da assistência. P7 confirmou esse padrão ao afirmar que alguns estudantes “[...] *ficam muito presos naquele modelo*” e passam a repetir o mesmo texto para pacientes distintos. P1 exemplificou a situação ao mencionar o registro de um recém-nascido como “*consciente e orientado*”, expressão inadequada ao contexto clínico.

Conforme Silva, Fritzen e Linch (2023) e Carvalho, Oliveira-Kumakura e Moraes (2017), a escrita clínica envolve processos mentais complexos de observação, julgamento e síntese que ultrapassam o simples preenchimento de padrões, exigindo que o profissional interprete as respostas humanas para selecionar intervenções apropriadas. O desenvolvimento do raciocínio clínico na escrita exige, portanto, progressão e *feedback* contínuo, de modo que o registro ultrapasse o preenchimento mecânico de formulários (Paese; Dal Sasso; Colla, 2018). Tais competências se

desenvolvem progressivamente quando as experiências formativas são articuladas a estratégias de *feedback* e *debriefing*³, que funcionam como etapas essenciais para suprir lacunas de conhecimento e permitir que o estudante reflita criticamente sobre sua prática.

Outra dificuldade refere-se à descrição do cuidado prestado. Estudos indicam que a baixa qualidade da documentação está associada à inserção de profissionais na prática assistencial sem formação que consolide a capacidade de observação clínica e de tomada de decisão, o que contribui para que o registro seja realizado de forma mecânica, sem refletir adequadamente a assistência prestada (Carrijo; Oguisso, 2006; Macedo; Lovadini; Sakamoto, 2020). No que se refere à seleção das informações registradas, observa-se a coexistência de dados redundantes ou pouco relevantes com a omissão de informações essenciais, limitando a função comunicativa do prontuário (Alves *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2025). Essa fragilidade torna-se particularmente evidente no registro do exame físico, em que dúvidas sobre o que e quando documentar resultam na ausência de dados necessários para a continuidade do cuidado (Ferreira *et al.*, 2020; Guardia *et al.*, 2024).

A insegurança emergiu como aspecto central nos relatos, com P4 e P5 concordando com sua ocorrência. P1 a associou diretamente à rotatividade entre setores:

“Acho que isso é geral, até porque imagina que ele passa lá um tempo de estágio, duas semanas na saúde da mulher, daqui a pouco já vai pra Cirúrgica, daqui a pouco já vai pra Pediatria. Então também é muita mudança, diferente de um funcionário que está há anos no mesmo setor, com a mesma terminologia, né”.

Tais relatos encontram respaldo em Campos, Sciavon e Camargos (2018) e Lima e Appolinário (2011), que identificam angústia e ansiedade como sentimentos

³O *feedback* constitui um processo unidirecional, do facilitador para o participante, com a finalidade de corrigir ações e melhorar o desempenho futuro, podendo ocorrer na forma de orientações ao longo da execução do cenário ou imediatamente após. O *debriefing*, por sua vez, é bidirecional e ocorre após a execução do cenário principal, consistindo em processo analítico e reflexivo por meio do qual os participantes são conduzidos à reflexão guiada e à auto identificação de pontos fortes e áreas de melhoria (Vilarinho, 2024).

frequentes no início dos estágios, sobretudo entre estudantes sem contato prévio com o ambiente hospitalar. Nesse contexto, a rotatividade frequente entre setores é apontada como fator que pode dificultar a adaptação ao processo assistencial e a qualificação progressiva da prática de registro (Barreto *et al.*, 2019).

A lentidão dos discentes na elaboração dos registros de enfermagem foi outra questão que emergiu nas falas e relaciona-se à insegurança e à carência de habilidades técnicas, fatores que elevam a ansiedade e dificultam a gestão do tempo no início da prática clínica (Campos; Sciavon; Camargos, 2018; Negri *et al.*, 2017). O tempo elevado dedicado à elaboração dos primeiros registros é mencionado em estudos que descrevem a fase inicial de adaptação como período de maior demanda temporal, no qual documentos assistenciais mais complexos exigem atenção e esforço adicionais (Costa; Portela, 2018; Reppetto; Souza, 2005). Esse cenário é agravado pela percepção de que a documentação exige tempo excessivo, podendo levar à priorização da assistência direta em detrimento das anotações sistemáticas (Barreto *et al.*, 2019).

Apesar dessas barreiras, P5 observou que tais obstáculos costumam integrar o processo formativo do aluno e P3 relembrou o caso de uma estudante que percebeu melhora ao comparar registros antigos com produções mais recentes. Espadaro (2023) e Perrenoud (2000) argumentam que o erro deve ser discutido de forma construtiva, constituindo elemento formativo e não apenas indicador de falha. Essa percepção de desenvolvimento ao longo da prática é corroborada por Pastore e Ferreira (2024) e Menegarde, Rodrigues e Conterno (2024), que indicam que a prática reiterada, o tempo de exposição às atividades e o suporte docente favorecem a superação da insegurança inicial, contribuindo para a construção da confiança e da habilidade necessárias à documentação adequada da assistência.

As fragilidades identificadas também se projetam sobre a dimensão ético-legal do registro. P5 afirmou que o prontuário pode ser utilizado “[...] *a favor ou contra*” o profissional, enfatizando a importância da escrita adequada. Essa percepção encontra respaldo na literatura, que reconhece o prontuário como documento legal utilizado na análise de responsabilidades profissionais e na defesa da equipe assistencial (Borges *et al.*, 2017; Carrijo; Oguisso, 2006). Nesse contexto, rasuras, ilegibilidade ou informações incompletas reduzem o valor documental do prontuário em eventuais

processos judiciais, afetando o respaldo legal do profissional e da instituição (COFEN, 2016; Millen, 2020; Setz; D'innocenzo, 2009).

Diante das dificuldades formativas, cognitivas e documentais descritas, torna-se necessário examinar como os docentes têm buscado responder a esses desafios no cotidiano do ensino. A seção seguinte analisa as estratégias pedagógicas adotadas para o desenvolvimento das competências de registro, bem como as limitações materiais e institucionais que condicionam sua efetividade.

4.4 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E LACUNAS MATERIAIS

Os docentes relataram o uso de diferentes estratégias pedagógicas para o ensino das anotações, adaptadas às disciplinas e aos cenários de prática. P7 descreveu uma mudança em sua organização didática ao passar a inserir pequenos trechos de anotação ao final de cada tema abordado, em vez de concentrar esse conteúdo apenas no encerramento da disciplina. A esse respeito, relatou:

“[...] em vez de falar de anotação só lá no final [...] dentro de cada tema da disciplina, eu trago uma anotação no final da aula, por exemplo, cuidados com as alterações respiratórias, falei de oxigenoterapia, de inalação [...] no final dessa aula, eu trago um trequinho do que seria uma anotação que contém as informações sobre o sistema respiratório. [...] lá no final, eles vão ter uma junção de todas as aulas, de cada sistema que foi trabalhado, cada procedimento [...] E agora eles só juntam”.

A inserção de registros parciais vinculados a cada tema visa superar a fragmentação do saber que prejudica a contextualização do cuidado (Fontana; Wachekowski; Barbosa, 2020), reduzindo a dissonância entre teoria e prática técnica (Neves, 2020). Esta estratégia alinha-se à proposta de currículo integrado em espiral, em que os conteúdos progridem conforme o amadurecimento discente, favorecendo o raciocínio clínico (Fioramonte; Marin; Pinto, 2022; Neves, 2020). Ao mobilizar conhecimentos prévios para a análise de novas informações, o modelo estimula a reflexão crítica e substitui a simples memorização pelo desenvolvimento contínuo de competências (Espadaro, 2023; Trindade Junior, 2017).

O uso de materiais normativos oficiais também foi mencionado, embora acompanhado de ressalvas. P7 citou resoluções do COFEN como referência para

orientar o que deve ser registrado em determinados procedimentos. P2, contudo, ponderou que esses documentos são extensos para a realidade do curso técnico e que o tempo disponível na disciplina de Fundamentos de Enfermagem não permite abordar todo o seu conteúdo, somando-se ainda às dificuldades de leitura apresentadas por parte dos estudantes. Essa percepção sugere um descompasso entre a abrangência das normativas profissionais e as condições didáticas concretas do curso. Fioramonte, Marin e Pinto (2022) discutem esse cenário ao apontarem a escassez de recursos pedagógicos elaborados especificamente para a formação técnica em enfermagem, situação que frequentemente leva os docentes a recorrerem a adaptações ou improvisações diante da ausência de materiais didáticos adequados.

A adequação do nível de exigência ao perfil formativo do técnico também foi apontada como preocupação recorrente. P5 alertou para a necessidade de não exigir competências que extrapolem a formação técnica, citando como exemplo o exame físico, abordado de forma básica e vinculado à observação e ao cuidado prestado pelo técnico. Essa ponderação reforça a necessidade de materiais que considerem as especificidades da categoria e o escopo legal de atuação, evitando a transposição direta de referenciais da graduação para o ensino técnico.

A leitura de registros reais durante o estágio configura recurso pedagógico relevante, pois permite ao estudante vivenciar situações concretas e relacionar teoria e prática assistencial (Benito *et al.*, 2012; Fontana; Wachekowski; Barbosa, 2020). P1 relatou que os estudantes acessam anotações de outros técnicos ao assumir o plantão ou ao consultar prontuários, o que possibilita observar diferentes formas de registro, identificar inconsistências e refletir sobre a própria escrita. Esse contato com situações reais aproxima a formação das demandas dos serviços e favorece o desenvolvimento do raciocínio crítico sobre a documentação (Linch *et al.*, 2017; Reibnitz *et al.*, 2016).

No entanto, observam-se limitações nessa estratégia quando utilizada sem mediação pedagógica, Guardia *et al.* (2024) indicam que a exposição passiva a modelos pode favorecer a mecanização do registro e a reprodução de práticas inadequadas. De modo semelhante, Ribeiro-Barbosa *et al.* (2020) e Fioramonte, Marin e Pinto (2022), apontam que abordagens centradas apenas na transmissão de conteúdos dificultam a superação da dicotomia entre teoria e prática. Assim, embora

a exposição a registros reais apresente potencial formativo, sua utilização requer acompanhamento pedagógico estruturado que favoreça a análise crítica das práticas observadas (Espadaro, 2023; Linch *et al.*, 2017; Santana *et al.*, 2019).

Apesar de a prática docente relatada priorizar a análise de registros reais durante o estágio, autores apontam a simulação clínica estruturada como potencialidade relevante ainda pouco explorada no ensino da documentação técnica. Segundo Mazzo *et al.* (2025), essa estratégia é plenamente viável na formação técnica, pois permite que o discente desenvolva autoconfiança por meio da prática repetida em ambiente protegido, o que contribui para reduzir a insegurança e a lentidão operacional observadas no início da trajetória clínica (Espadaro, 2023). A adoção de cenários que integrem a assistência à escrita assistencial, culminando no *debriefing*, etapa fundamental para a reflexão sobre a fidedignidade do registro, possibilita a consolidação do raciocínio clínico antes da interação com o paciente real (Aquino *et al.*, 2025; COREN-SP, 2022).

A demanda por materiais didáticos específicos emergiu como eixo central nas falas dos participantes. P7 sugeriu a elaboração de materiais organizados por procedimentos, com indicação dos elementos essenciais que “[...] *não podem faltar*”, como calibre do cateter, veia puncionada e motivo da retirada. P3 destacou a necessidade de que esses materiais estejam alinhados às diretrizes atualizadas do COFEN e dos Conselhos Regionais de Enfermagem. P5, por sua vez, descreveu uma estratégia baseada em perguntas orientadoras que explicitam o encadeamento do raciocínio clínico: “[...] *como ele está, o que ele apresenta, o que eu realizo e como ele ficou*”. Estudos indicam que perguntas estruturantes podem contribuir para a organização lógica e a completude dos registros, ao oferecerem ao estudante um roteiro mental que orienta a observação, a síntese e a transposição do cuidado para a escrita (Neves, 2020; Sales *et al.*, 2025). Essa abordagem dialoga com a lógica do método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), ao propor uma sequência que parte da condição do paciente, percorre a intervenção realizada e conclui com o resultado observado, contribuindo para que o registro reflita a continuidade do raciocínio clínico e não apenas o cumprimento de uma tarefa burocrática.

Quanto aos materiais já utilizados no ensino, foram mencionados livros de Fundamentos de Enfermagem e artigos científicos. P5 relatou utilizar artigos para evidenciar deficiências e falhas nos registros, conforme ilustra o relato:

“[...] utilizo alguns artigos pra mostrar as deficiências, onde é que estão as falhas da anotação de enfermagem, pra eles entenderem a importância da anotação de enfermagem pra aquele cenário, pra que ele entenda as questões legais que envolvem a anotação”.

Quanto ao tipo de material considerado adequado pelos docentes, foram mencionados formatos interativos e digitais. P8 propôs *“[...] algo virtual no sentido em que toda a trajetória [...] não seja uma leitura, mas algo que chame o aluno a caminhar, como se fosse uma trilha”*. P1 sugeriu a criação de um aplicativo com apoio de inteligência artificial, no qual o sistema indicaria informações a serem complementadas conforme as ações selecionadas pelo estudante. P7 mencionou ainda a utilização de jogos como recurso didático, estratégia que possibilita transferir o conhecimento construído para situações de prática (Fontana; Wachekowski; Barbosa, 2020). Essas propostas dialogam com abordagens pedagógicas que combinam atividades autodirigidas e flexíveis, favorecendo a aprendizagem ativa (Salvador *et al.*, 2019). O uso dessas ferramentas, contudo, exige mediação docente qualificada. P8 alertou que a utilização de inteligência artificial pode afastar o estudante do processo de reflexão sobre a própria prática, comprometendo sua capacidade de formular perguntas clínicas. Estudos indicam que recursos tecnológicos, por mais avançados que sejam, não substituem dimensões humanas do cuidado, como a empatia, a experiência sensível e a tomada de decisão ética diante de situações de incerteza (Floriz *et al.*, 2025; Silva; Fritzen; Lynch, 2023).

Por fim, houve consenso entre os participantes quanto à utilidade de exemplos práticos acompanhados da análise de erros. A comparação entre anotações adequadas e inadequadas, a identificação de lacunas e exercícios de localização de inconsistências foram apontados como estratégias que favorecem o desenvolvimento do raciocínio clínico na escrita. Essas propostas dialogam com Perrenoud (2000), que compreende o erro como indicador dos mecanismos de pensamento do aprendiz e como elemento relevante para a intervenção pedagógica.

Estratégias baseadas na análise de situações clínicas concretas também são descritas por Melo *et al.* (2019) e Linch *et al.* (2017), que identificaram melhorias na qualidade dos registros após intervenções educativas estruturadas. Nessa perspectiva, a mediação docente sistemática e a utilização de espaços coletivos de reflexão sobre falhas observadas favorecem a problematização das práticas e a revisão de condutas, contribuindo para o aprimoramento gradual da escrita clínica (Santana *et al.*, 2019).

4.5 FORMAÇÃO DOCENTE: SABERES CONSTRUÍDOS NA PRÁXIS

As falas dos participantes evidenciaram percepções sobre os limites da formação pedagógica inicial para o ensino no nível técnico. P5 afirmou que, durante a graduação, recebeu formação voltada à execução das práticas profissionais, como a realização de anotações e evoluções de enfermagem, mas não ao ensino dessas práticas a estudantes técnicos. P1 relatou trajetória distinta por ter cursado licenciatura e possuir experiência docente anterior, ainda assim, reconheceu que o ensino da documentação de enfermagem não foi abordado de forma sistemática em sua formação inicial. Em ambos os relatos, observa-se que a competência para ensinar a documentação não foi estruturada academicamente, sendo desenvolvida posteriormente na prática docente.

Esses relatos alinham-se a estudos que indicam que enfermeiros-docentes do ensino técnico apresentam, em geral, sólida experiência assistencial, mas formação pedagógica incipiente, tendendo a buscar qualificação para a docência apenas após um percurso já trilhado na prática do ensino (Franco; Fernandes; Millão, 2020). A formação docente nesse campo encontra-se, portanto, ainda enraizada na transferência do saber de forma expositiva, o que dificulta a incorporação de abordagens pedagógicas inovadoras e aponta para a necessidade de capacitação docente contínua (Ribeiro-Barbosa *et al.*, 2020).

O colegiado docente foi descrito como espaço relevante de construção coletiva de saberes pedagógicos. P8 relatou que em determinado momento dificuldades observadas na prática simulada, especificamente na realização dos registros, foram discutidas coletivamente, resultando em ajuste pedagógico para distribuir o ensino da

anotação ao longo das aulas, com a inclusão de “[...] *um pedacinho de anotação*” em cada tema trabalhado no semestre. P1 mencionou reorganizações frequentes no grupo, associadas à entrada e saída de docentes, destacando a necessidade contínua de discutir e reorganizar o trabalho pedagógico. Esses movimentos aproximam a experiência relatada da noção de aprendizagem docente em serviço, na qual o desenvolvimento pedagógico emerge da reflexão coletiva sobre problemas concretos do ensino (Franco; Fernandes; Millão, 2020; Neves, 2020).

Outro ponto relevante diz respeito ao ajuste de expectativas na transição da docência do ensino superior para a formação técnica. Conforme discutido na seção anterior, P7 e P5 sinalizaram a necessidade de adequar o nível de exigência às atribuições profissionais do técnico de enfermagem. Esse ajuste exige a delimitação de conteúdos essenciais que respeitem o escopo de atuação da categoria, evitando a exigência de competências que ultrapassem o nível médio (Pastore; Ferreira, 2024). Tal adequação pedagógica busca superar processos formativos fragmentados que nem sempre dialogam com a realidade do estudante (Adamy *et al.*, 2023) e reflete o desafio do enfermeiro-docente em ressignificar sua prática para construir estratégias de ensino próprias da educação profissional (Góis; Azevedo; Rodrigues, 2022).

Os estágios supervisionados foram descritos como espaço decisivo para o desenvolvimento da competência documental. P1 afirmou que determinadas habilidades relacionadas à anotação não se consolidam exclusivamente em sala de aula, estruturando-se a partir da vivência prática em diferentes cenários assistenciais. P3 destacou como diferencial institucional o fato de os mesmos docentes acompanharem teoria e estágio, favorecendo a continuidade no ensino. Estudos sobre formação profissional indicam que a supervisão qualificada atua como mediação entre conhecimento teórico e prática profissional (Corrêa; Souza; Clapis, 2021), ao mesmo tempo em que alertam que nem todos os contextos educacionais dispõem dessa estrutura de acompanhamento sistemático (Ribeiro-Barbosa *et al.*, 2020).

Os relatos indicam que a formação docente para o ensino das anotações no nível técnico se constrói na articulação entre experiência prática, reflexão coletiva e mediação nos estágios, configurando um processo de aprendizagem profissional desenvolvido no próprio exercício da docência. Essa dinâmica aproxima-se do que é descrito como saberes experienciais, compreendidos como conhecimentos

produzidos na prática cotidiana do ensino e incorporados progressivamente a partir da reflexão sobre situações concretas de trabalho (Tardif, 2002). Segundo o autor, tais saberes não são plenamente transmissíveis por meio da formação inicial, constituindo-se ao longo da trajetória profissional. Nos relatos de P1 e P5, essa trajetória aparece de forma explícita: a competência para ensinar a documentação não foi construída academicamente, mas desenvolvida ao longo da prática docente, pela exposição a dificuldades reais e pela busca de respostas pedagógicas situadas. Assim, o ensino das anotações emerge como saber profissional construído no próprio processo de ensinar, mediado pela experiência e pela reflexão sobre o cotidiano formativo.

O colegiado docente surge nesse contexto como espaço institucional que potencializa esse processo. As decisões coletivas relatadas, como o ajuste pedagógico descrito por P8 a partir de fragilidades identificadas na prática simulada, indicam que a reflexão compartilhada entre pares opera como mediação entre a experiência individual e a reorganização pedagógica coletiva. Esse movimento, descrito por Tardif (2002) como constitutivo do desenvolvimento profissional docente, sugere que a qualificação do ensino das anotações de enfermagem no nível técnico depende não apenas de formação pedagógica inicial, mas da criação de condições institucionais que sustentem a reflexão coletiva sobre a prática.

Tomados em conjunto, os achados das seções anteriores convergem para um cenário em que déficits formativos prévios, fragilidades no raciocínio clínico, lacunas materiais e limitações na formação pedagógica docente configuram desafios interdependentes. Esse diagnóstico reforça a pertinência de iniciativas que ofereçam, simultaneamente, suporte didático ao docente e orientação prática ao discente, articulação que fundamenta a proposição do produto educacional desenvolvido nesta pesquisa.

4.6 SÍNTESE DOS ACHADOS E IMPLICAÇÕES PARA O PRODUTO EDUCACIONAL

A análise integrada dos achados indica que o ensino das anotações de enfermagem na formação técnica é reconhecido pelos docentes como componente

relevante do cuidado, desenvolvido ao longo do curso por meio de diferentes estratégias pedagógicas. As falas evidenciam, contudo, que tais estratégias dependem em grande medida de iniciativas individuais e ajustes locais, diante da ausência de materiais didáticos sistematizados e especificamente elaborados para o nível técnico.

Os resultados revelam um cenário em que três dimensões se retroalimentam. Os déficits formativos prévios e as fragilidades no raciocínio clínico dos estudantes expõem demandas que as estratégias pedagógicas disponíveis não conseguem suprir plenamente, seja pela escassez de materiais específicos, seja pela predominância de abordagens centradas na transmissão de conteúdo. Essas lacunas, por sua vez, são agravadas pelos limites da formação pedagógica docente, que indicam que a competência para ensinar a documentação se constrói no próprio exercício da docência, sem respaldo estruturado da formação inicial. Essa convergência configura um ciclo no qual dificuldades discentes, insuficiência de recursos pedagógicos e fragilidades na preparação docente se condicionam mutuamente, reforçando a necessidade de dispositivos que atuem simultaneamente como suporte ao ensino e como orientação à prática do registro.

Os espaços de aprendizagem prática como o estágio supervisionado e o colegiado docente foram descritos como contextos nos quais parte das lacunas descritas encontra mediação. É no estágio que os estudantes produzem registros vinculados à observação clínica e identificam inadequações em anotações reais, e é no colegiado que os docentes compartilham dificuldades e reorganizam coletivamente suas estratégias de ensino. Ambos os espaços operam como instâncias de construção de saberes experienciais (Tardif, 2002), mas sua efetividade depende de condições institucionais nem sempre disponíveis, como supervisão qualificada, continuidade do acompanhamento docente e tempo para reflexão compartilhada (Corrêa; Souza; Clapis, 2021; Ribeiro-Barbosa *et al.*, 2020).

No que se refere às implicações para o produto educacional, os achados delineiam diretrizes derivadas das demandas expressas pelos próprios participantes: linguagem compatível com o nível técnico, organização do conteúdo a partir de procedimentos recorrentes na prática assistencial, explicitação dos elementos essenciais que devem compor cada tipo de anotação, apresentação de erros

freqüentes acompanhados de versões corrigidas e utilização de perguntas orientadoras para apoiar a organização do raciocínio clínico na escrita. Essa última estratégia, sintetizada por P5 na sequência “[...] *como ele está, o que ele apresenta, o que eu realizo e como ele ficou*”, oferece ao estudante um roteiro mental que estrutura a transposição do cuidado para o registro, contribuindo para que a anotação reflita o encadeamento do pensamento clínico e não apenas o cumprimento de uma exigência formal.

Como possibilidades complementares, os participantes sugeriram o desenvolvimento de recursos digitais e interativos, incluindo trilhas de aprendizagem, jogos educativos e ferramentas com apoio de inteligência artificial. A simulação clínica estruturada é tida como estratégia relevante para a consolidação das competências documentais em ambiente protegido, especialmente na fase inicial da formação (COREN-SP, 2022; Mazzo *et al.*, 2025). Tais recursos, contudo, devem ser concebidos como apoio ao processo de aprendizagem e não como substituição do julgamento clínico, preservando a centralidade da reflexão, da experiência sensível e da tomada de decisão ética no cuidado de enfermagem (Floriz *et al.*, 2025; Silva; Fritzen; Linch, 2023).

4.6.1 Limitações do estudo

Este estudo apresenta limitações relacionadas às escolhas metodológicas e ao delineamento institucional adotado. A pesquisa foi realizada em um único Instituto Federal, o que restringe a transferibilidade dos achados para outros contextos educacionais, especialmente instituições privadas ou escolas com distintas condições de infraestrutura e organização do trabalho docente.

Outra limitação refere-se à ausência da perspectiva discente. As dificuldades relacionadas às anotações de enfermagem foram examinadas exclusivamente a partir do olhar dos docentes, com base em relatos consistentes e exemplos recorrentes, sem a inclusão direta das percepções dos estudantes. Essa opção metodológica, alinhada ao objetivo da pesquisa centrado nas práticas e concepções docentes, sinaliza possibilidade de aprofundamento em investigações futuras.

O recorte temporal da produção dos dados também configura limitação, uma vez que o grupo focal foi realizado em momento único, não permitindo acompanhar mudanças ao longo do curso nem transformações decorrentes de ajustes pedagógicos subsequentes. A pesquisa baseou-se, ademais, em relatos discursivos, sem observação direta das práticas de ensino em sala de aula, laboratórios ou campos de estágio.

Cabe ainda considerar limitação inerente à técnica do grupo focal: a dinâmica interacional entre os participantes pode influenciar os relatos produzidos, seja pela tendência à concordância com posições já expressas pelo grupo, seja pela inibição de percepções divergentes diante dos pares. Embora essa característica seja constitutiva da técnica e não invalide os dados produzidos, implica reconhecer que os discursos coletados expressam construções situadas no contexto da interação grupal, e não necessariamente a totalidade das percepções individuais dos participantes (Dall'agnol; Trench, 1999).

Por fim, o estudo não contemplou avaliação direta das anotações produzidas pelos estudantes ao longo do curso. Essa característica é inerente ao delineamento qualitativo adotado, cujo objeto são as percepções e práticas dos participantes. Os achados delimitam-se, portanto, às concepções e estratégias docentes relativas ao ensino das anotações, sem extensão de conclusões ao desempenho documental dos estudantes.

4.6.2 Contribuições do estudo

A presente pesquisa amplia a discussão sobre o ensino das anotações de enfermagem na educação profissional técnica ao examinar, de forma sistematizada, os sentidos produzidos por docentes de um Instituto Federal acerca dessa competência. A literatura consultada aponta a escassez de estudos especificamente dedicados à abordagem pedagógica das anotações no nível técnico, evidenciando uma lacuna para a qual esta pesquisa busca contribuir.

Os resultados evidenciaram distanciamentos entre a prática assistencial e o registro, inseguranças no preenchimento das anotações e ausência de materiais didáticos estruturados para esse conteúdo, permitindo compreender a documentação

não apenas como exigência formal, mas como dimensão formativa que envolve mediação pedagógica e organização curricular. Ao adotar a Análise do Discurso na perspectiva de Orlandi (2001), a investigação examinou os processos de produção de sentidos no espaço educativo, ampliando o alcance interpretativo em relação às abordagens predominantemente temáticas identificadas na área.

A partir desses achados, a pesquisa resultou na elaboração de um manual direcionado à formação técnica em enfermagem, estruturado com base nas categorias analíticas emergentes e nas necessidades formativas identificadas. Diferentemente de guias normativos ou de materiais voltados prioritariamente ao enfermeiro, o manual organiza o conteúdo com foco na formação inicial do técnico de enfermagem, articulando fundamentos legais, critérios de registro e exemplos contextualizados ao cotidiano da prática formativa.

Ao integrar diagnóstico empírico, fundamentação normativa e desenvolvimento de recurso pedagógico, o estudo contribui para ampliar a reflexão sobre o ensino da documentação de enfermagem na educação profissional técnica e oferece subsídios para o aprimoramento das práticas formativas nesse campo.

5 PRODUTO TÉCNICO

O produto técnico desenvolvido nesta pesquisa consiste em um Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem no Ensino Técnico, concebido como instrumento pedagógico voltado ao desenvolvimento de competências relacionadas à documentação clínica. Sua elaboração fundamenta-se nos achados do grupo focal apresentados na Seção 4, que evidenciaram a necessidade de um material didático específico para o nível técnico, com linguagem acessível, exemplos aplicados e organização orientada por situações clínicas.

O manual foi construído a partir da articulação de quatro eixos: evidências científicas sobre o ensino de registros de enfermagem; normativas profissionais vigentes, análise documental do PPC e os achados empíricos do grupo focal realizado com docentes. Essa integração assegurou fundamentação científica, alinhamento normativo e coerência com a realidade institucional.

A organização do conteúdo segue progressão pedagógica que conduz o estudante da compreensão da função dos registros de enfermagem à sua aplicação prática, considerando critérios técnicos, éticos e legais. O material aborda a relevância das anotações para a continuidade do cuidado, a comunicação profissional e a segurança do paciente, além de delimitar conceitualmente as características de um registro adequado.

São apresentados elementos estruturais que orientam a construção da anotação de forma sistematizada, com diretrizes voltadas à organização das informações, clareza descritiva e objetividade. O manual contempla ainda orientações sobre linguagem clínica e padronização terminológica, incluindo o uso adequado da nomenclatura anatômica, bem como a identificação de erros recorrentes e procedimentos formais para correção de registros no prontuário, em conformidade com princípios éticos e normativos.

Além da fundamentação conceitual, o material reúne modelos aplicáveis a diferentes áreas clínicas, exercícios práticos e instrumento de autoavaliação, favorecendo aprendizagem ativa e desenvolvimento progressivo da competência documental. As referências utilizadas sustentam teoricamente o conteúdo apresentado.

Entre as características pedagógicas destacam-se: linguagem adequada ao nível técnico; progressão gradual de complexidade; organização orientada por situações concretas de cuidado; ênfase na completude e pertinência do registro; utilização de recursos visuais facilitadores; e integração entre base teórica, aplicação prática e respaldo normativo. Essas escolhas alinham-se à perspectiva de que a formação técnica requer articulação entre conhecimento normativo, raciocínio clínico e prática contextualizada, favorecendo a construção de competências documentais, conforme apontam Neves (2020) e Fioramonte, Marin e Pinto (2022).

O produto responde às demandas identificadas no grupo focal, no qual os docentes relataram dificuldades relacionadas ao vocabulário técnico, à organização textual e à limitação de tempo para prática. Tais fragilidades foram contempladas por estratégias específicas, como glossário técnico, explicitação estruturada do método SOAP com exemplos, modelos organizados por área clínica, abordagem das dimensões ética e legal da documentação e ampliação de exercícios práticos.

O manual será disponibilizado em formato digital para docentes e estudantes do Curso Técnico em Enfermagem do IFPR-Curitiba, podendo ser utilizado em aulas teóricas, laboratórios de habilidades, práticas simuladas, preparação pré-estágio, estágios supervisionados e estudos orientados. O formato digital permite atualização conforme alterações normativas ou ajustes curriculares.

O manual integra as ações de ensino e extensão do IFPR e constitui contribuição aplicada à qualificação da formação técnica em enfermagem, área em que ainda são limitados os materiais didáticos especificamente voltados a esse nível de ensino. A ficha técnica completa do produto encontra-se no Anexo C.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como propósito compreender as práticas docentes relacionadas ao ensino das anotações de enfermagem no Curso Técnico em Enfermagem do IFPR, Campus Curitiba, e desenvolver um Manual de Boas Práticas voltado à qualificação da documentação clínica no contexto formativo. A abordagem metodológica adotada permitiu articular revisão de literatura, análise documental, dados empíricos oriundos do grupo focal e normativas profissionais vigentes, constituindo base consistente para a elaboração do produto educacional.

Os resultados evidenciaram que o ensino das anotações de enfermagem constitui um processo complexo na formação técnica, atravessado por desafios relacionados ao domínio da língua portuguesa, à apropriação de terminologia específica, à compreensão das implicações ético-legais dos registros e à articulação entre teoria, simulação e prática assistencial. Embora o tema esteja presente em diferentes componentes curriculares, os relatos indicam a necessidade de maior sistematização pedagógica e de explicitação das responsabilidades profissionais envolvidas na documentação clínica, aspectos diretamente relacionados ao exercício ético da enfermagem.

O grupo focal também revelou uma organização colegiada estruturada no curso, marcada por planejamento coletivo, reuniões sistemáticas e continuidade pedagógica entre teoria, prática e estágio supervisionado. Essa dinâmica institucional mostrou-se favorável à análise de fragilidades formativas e à construção de estratégias ajustadas às demandas identificadas no processo formativo. O diálogo com a literatura permitiu situar a articulação entre raciocínio clínico, documentação, simulação e referenciais normativos do COFEN como elemento relevante para a qualificação do cuidado na formação técnica em enfermagem.

Nesse contexto, o Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem foi concebido como resposta fundamentada às demandas identificadas empiricamente. A integração entre achados do grupo focal, diretrizes normativas e documentos institucionais orientou a elaboração de instrumento didático com linguagem adequada ao nível técnico, organização por áreas clínicas e exemplos

contextualizados, em consonância com a realidade do curso e com as atribuições legais do técnico em enfermagem.

Os objetivos propostos foram alcançados ao descrever as práticas docentes relacionadas ao ensino das anotações, analisar criticamente o contexto formativo investigado e desenvolver um recurso educacional alinhado às necessidades identificadas. A análise sustenta que o desenvolvimento da competência documental exige mais do que a transmissão de normas, demandando mediações pedagógicas explícitas, integração curricular e acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem.

Como limitações, destaca-se que o manual não foi validado junto ao público-alvo nem submetido à validação de conteúdo por especialistas, em razão das delimitações temporais do mestrado profissional. Também não foi possível avaliar seu impacto na qualidade das anotações produzidas pelos estudantes, o que requereria delineamento longitudinal com análise comparativa pré e pós-intervenção. Tais etapas configuram desdobramentos recomendados para pesquisas futuras.

Como implicações para o ensino, recomenda-se a incorporação do manual às práticas pedagógicas do curso, em aulas teóricas, atividades laboratoriais, simulações e estágios supervisionados, com atualização periódica conforme alterações normativas e curriculares. Sugere-se, ainda, que estudos subsequentes realizem sua validação com estudantes e especialistas, avaliem sua aplicabilidade em diferentes contextos institucionais, desenvolvam instrumentos sistemáticos de avaliação da competência documental ao longo da formação e investiguem seu impacto na qualidade dos registros produzidos pelos estudantes.

Entende-se que o manual, ao dialogar com demandas concretas do contexto investigado e fundamentar-se em evidências científicas e normativas vigentes, constitui recurso pedagógico com potencial para apoiar o ensino das anotações de enfermagem e contribuir para a qualificação da documentação clínica na formação técnica. Mais do que produto final, configura-se como instrumento articulado às práticas docentes e à compreensão da anotação como dimensão integrante do cuidado em enfermagem.

REFERÊNCIAS

- ADAMY, E. K. *et al.* Panorama Nacional da Formação em Enfermagem: Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Técnica e da Graduação. *In*: ADAMY, E. K.; CUBAS, M. R. (org.). **Os sentidos da inovação tecnológica no ensino e na prática do cuidado em enfermagem: reflexões do 18º SENADEN e 15º SINADEN.** Brasília, DF: Aben, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51234/aben.23.e20c2>.
- ALMEIDA, D. B. *et al.* (org.). **Processo de enfermagem e sistematização da assistência: possibilidades e perspectivas de qualificação do cuidado.** Salvador: EDUFBA, 2023. Ebook. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/36983/14/processo-de-enfermagem-e-sistematizacao-da-assistencia_RI.pdf. Acesso em: 16 fev. 2026.
- ALVES, R. S. *et al.* Qualidade de anotações e Registros de enfermagem e saúde. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, [s.l.], v. 16, n. 2, p. 1-7, 2024. Disponível em: <https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/view/1928/1381> . Acesso em: 11 fev. 2026.
- AMADEI, J. **Percepção dos profissionais enfermeiros sobre os registros da assistência de enfermagem e sua atuação profissional no Instituto Federal Catarinense.** 2024. Dissertação (Mestrado Profissional) – Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Instituto Federal Catarinense, Blumenau, 2024.
- AMERICAN NURSES ASSOCIATION. **Principles for nursing documentation: guidance for registered nurses.** Silver Spring: Nursesbooks.org, 2010. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://www.nursingworld.org/globalassets/docs/ana/ethics/principles-of-nursing-documentation.pdf> . Acesso em: 26 jan. 2026.
- AQUINO, A. C. O. *et al.* Barreiras e facilitadores para a realização do registro eletrônico do processo de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s.l.], v. 25, p. 1-11, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/REAS.e18855.2025> . Acesso em: 26 jan. 2026.
- ÁVILA, G. S. *et al.* Prontuário eletrônico na gestão do cuidado em equipes de saúde da família. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 27, e79641, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/ce.v27i0.79641> . Acesso em: 3 fev. 2026.
- AZEVEDO, O. A.; CRUZ, D. A. L. M. Quality indicators of the nursing process documentation in clinical practice. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, n. 3, p. 1-8, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1355>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BARRETO, J. J. S. *et al.* Registros de enfermagem e os desafios de sua execução na prática assistencial. **REME – Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte, v. 23, p. 1-7, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1415-2762.20190082>. Acesso em: 27 jan. 2026.

BENITO, G.A.V. *et al.* Desenvolvimento de competências gerais durante o estágio supervisionado. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 65, n. 1, p. 172-178, 2012. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scielo.br/j/reben/a/666nz3qZRSPVxQTCVK9yc7c/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 23 jan. 2026.

BETTANIN, F. S. M.; RODRIGUES, J. C.; BACCI, M. R. Educação permanente em saúde como instrumento da qualidade assistencial. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 7, p. 42986-42992, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-060>. Acesso em: 11 fev. 2026.

BORGES, F. F. D. *et al.* Importância das anotações de enfermagem segundo a equipe de enfermagem: implicações profissionais e institucionais. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, Divinópolis, v. 7, p. 1-8, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19175/recom.v7i0.1147>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987**. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1987. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d94406.htm. Acesso em: 27 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973**. Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1973. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5905.htm . Acesso em: 13 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986**. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso em: 27 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018.** Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Brasília, DF: Presidência da República, 2018b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13787.htm. Acesso em: 13 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** 4. ed. Brasília, DF: MEC/SETEC, 2020. Disponível em: <http://cnct.mec.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, p. 22, 21 set. 2012. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seb-1/pdf/rceb006_12_ED.pdf. Acesso em: 1 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, p. 19-23, 6 jan. 2021. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/resolucoes-do-cne/cp/2021/rcp001_21.pdf. Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. Ebook. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume9.pdf. Acesso em: 11 mar. 2026.

CABRAL, K. B. *et al.* Prontuário eletrônico na atenção primária à saúde sob a óptica dos profissionais de enfermagem. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s.l.], v. 24, n. 8, p. 1-8, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e16508.2024>. Acesso em: 3 fev. 2026.

CAMARGO, L. R. L.; PEREIRA, G. R. Análise dos registros realizados pela enfermagem e o possível impacto na auditoria: uma revisão da literatura nacional. **Revista de Administração em Saúde**, São Paulo, v. 17, n. 68, p. 1-10, 2017. Disponível em: <https://cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/55>. Acesso em: 27 jan. 2026.

CAMPOS, I. C. M.; SCIAVON, I. C. A.; CAMARGOS, A. T. Dificuldades e desafios na educação profissional técnica de nível médio em enfermagem. **ScientiaTec: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS**, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 65-82, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec/article/view/7100/3504>. Acesso em: 10 jan. 2026.

CANZONIERI, A. M. **Metodologia da pesquisa qualitativa na saúde.** Petrópolis: Vozes, 2010.

CAREGNATO, R. C. A.; MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise de conteúdo. **Texto & Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 15, n. 4, p. 679-684, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072006000400017>. Acesso em: 27 jan. 2026.

CARRIJO, A. R.; OGUISO, T. Trajetória das Anotações de Enfermagem: um levantamento em periódicos nacionais (1957-2005). **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 59, n. esp., p. 454-458, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/yn9VVgVSnbMRSfPkm3Vp8tt/?format=html&lang=pt> . Acesso em: 11 fev. 2026.

CARVALHO, E. C.; OLIVEIRA-KUMAKURA, A. R. S.; MORAIS, S. C. R. V. Raciocínio clínico em enfermagem: estratégias de ensino e instrumentos de avaliação. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 70, n. 3, p. 690-696, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0509> . Acesso em: 15 jan. 2026.

CELUPPI, I. C. *et al.* Dez anos do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS: em busca de um Sistema Único de Saúde eletrônico. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 58, n. 23, p. 1-11, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2024058005770> . Acesso em: 11 fev. 2026.

CERCILIER, P. *et al.* Sistematização da Assistência de Enfermagem: uma década de implementação sob a ótica do enfermeiro. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, Rio de Janeiro, v. 95, n. 34, e021055, 2021. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com.br/revista/article/view/996/871> . Acesso em: 27 jan. 2026.

CERETTA, J.; KINALSKI, S. S.; CALLEGARO, A. R. C. Impacto dos registros de enfermagem no processo de auditoria. **Revista GESTO: Revista de Gestão Estratégica de Organizações**, Santo Ângelo, v. 11, n. 2, p. 25-23, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.31512/gesto.v11i2.1380>.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Enfermagem em números**. Brasília, DF: COFEN, 2026. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/enfermagem-em-numeros>. Acesso em: 20 fev. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Guia de recomendações para registro de enfermagem no prontuário do paciente e outros documentos de enfermagem**. Brasília, DF: COFEN, 2016. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-de-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-CTLN-Vers%C3%A3o-Web.pdf> . Acesso em: 27 jan. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Recomendações para registros de enfermagem no exercício da profissão**. Brasília, DF: COFEN, 2023. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/Registros-de-Enfermagem-no-Exercicio-da-Profissao.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução COFEN nº 564, de 6 de novembro de 2017**. Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Brasília, DF: COFEN, 2017. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017/>. Acesso em: 10 jan. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024**. Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Brasília, DF: COFEN, 2024a. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>. Acesso em: 10 jan. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução COFEN nº 754, de 16 de maio de 2024**. Normatiza o uso do prontuário eletrônico e plataformas digitais no âmbito da Enfermagem: digitalização, utilização de sistemas informatizados para guarda e armazenamento nesta tecnologia. Brasília, DF: COFEN, 2024b. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-754-de-16-de-maio-de-2024/>. Acesso em: 27 jan. 2026.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. **Anotação de Enfermagem**. São Paulo: COREN-SP, 2022.

CORRÊA, A. K.; SOUZA, M. C. B. M.; CLAPIS, M. J. Middle-level technical professional education in health/nursing in the Unified Health System. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 10, e401101019068, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.19068>. Acesso em: 30 jan. 2026.

COSTA, J. F. R.; PORTELA, M. C. Percepções de gestores, profissionais e usuários acerca do registro eletrônico de saúde e de aspectos facilitadores e barreiras para a sua implementação. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, p. 1-14, 2018. DOI: 10.1590/0102-311X00187916.

DALL'AGNOL, C. M.; TRENCH, M. H. Grupos focais como estratégia metodológica em pesquisas na enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 20, n. 1, p. 5-25, 1999. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/rgenf/article/view/4218/2228> . Acesso em: 25 fev. 2026.

DODO, N. B. *et al.* Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem em um hospital do Norte do Brasil. **Enfermagem em Foco**, Brasília, v. 11, n. 4, p. 202-207, 2020. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3125>. Acesso em: 10 jan. 2026.

DUARTE, S. C. M. *et al.* Segurança do paciente: compreendendo o erro humano na assistência de enfermagem em terapia intensiva. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 52, p. 1-8, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017042203406>. Acesso em: 10 jan. 2026.

DUTRA, M. O. M.; SILVA, J. J. S.; ARAÚJO, M. G. O. Contribuições do prontuário eletrônico para pacientes, profissionais e instituições de saúde: uma revisão integrativa. **Revista Interdisciplinar em Saúde**, Cajazeiras, v. 7, n. 1, p. 1448-1460, 2020. DOI: 10.35621/23587490.v7.n1.p1448-1460.

ESPADARO, R. F. A simulação realística como prática educacional na formação da enfermagem contemporânea. **EccoS – Revista Científica**, São Paulo, n. 66, p. 1-13, 2023. DOI: 10.5585/eccos.n66.25158. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/eccos.n66.25158> . Acesso em: 11 fev. 2026.

FERREIRA, L. L. *et al.* Análise dos registros de técnicos de enfermagem e enfermeiros em prontuários. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 2, e20180542, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0542>. Acesso em: 10 jan. 2026.

FIORAMONTE, G. L. N.; MARIN, M. J. S.; PINTO, A. A. M. Avanços e desafios na formação técnica de enfermagem: revisão integrativa da literatura. **Saberes Plurais: Educação na Saúde**, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 1-17, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.54909/sp.v6i2.128211>. Acesso em: 10 jan. 2026.

FLORÊNCIO, P. C. S.; MELO, A. L. C. D.; MERCADO, L. P. L. Ensino técnico em enfermagem: novas estratégias pedagógicas com metodologias ativas e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. **HOLOS**, Natal, ano 40, v. 6, p. 1-18, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.15628/holos.2024.16241>. Acesso em: 27 jan. 2026.

FLORZ, E. T. *et al.* A Inteligência Artificial na Formação em Saúde: Desafios Bioéticos e Implicações para a Prática Profissional. **Revista de Gestão e Secretariado – GeSec**, São José dos Pinhais, v. 16, n. 8, p. 1-18, 2025. Disponível em: <http://doi.org/10.7769/gesec.v16i8.5173>. Acesso em: 27 jan. 2026.

FONTANA, R. T.; WACHEKOWSKI, G.; BARBOSA, S. S. N. As Metodologias Usadas no Ensino de Enfermagem: com a palavra, os estudantes. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 36, e220371, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-4698220371>. Acesso em: 11 fev. 2026.

FONTANELLA, B. J. B. *et al.* Amostragem em pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação teórica. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 389-394, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/3bsWNzMMdvYthrNCXmY9kJQ/?lang=pt> . Acesso em: 27 jan. 2026.

FRANCO, M. T.; FERNANDES, M. T. C.; MILÃO, L. F. Perfil de enfermeiros-professores da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem. **Saúde Coletiva**, Barueri, v. 10, n. 56, p. 3164-3169, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2020v10i56p3164-3175>. Acesso em: 30 jan. 2026.

FREITAS, J. R. Ensino de Enfermagem: desafios e estratégias para alunos de diferentes faixas etárias. **RevistaFT**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 138, 2024. DOI: 10.69849/revistaft/th10249301927.

GARCIA, T. R.; NÓBREGA, M. M. L. Processo de enfermagem: da teoria à prática assistencial e de pesquisa. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 188-193, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000100026>. Acesso em: 10 jan. 2026.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/>. Acesso em: 27 jan. 2026.

GÓIS, F. A.; AZEVEDO, G. R.; RODRIGUES, C. I. S. Desafios na educação em nível técnico de enfermagem: uma proposta pedagógica. **Boletim Técnico Do Senac**, Rio de Janeiro, v. 48, p. 1-16, 2022. Disponível em: <https://www.bts.senac.br/bts/article/view/865> . Acesso em: 10 jan. 2026.

GONÇALVES, B. S. *et al.* Processo de trabalho do enfermeiro: a importância da anotação de enfermagem na segurança do paciente. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, São José do Pinhais, v. 17, n. 13, p. 1-15, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.13-197>. Acesso em: 27 jan. 2026.

GONÇALVES, T. S.; BANASZESKI, C. L. O impacto dos registros de enfermagem na assistência à saúde e sua relação com as glosas hospitalares. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, Curitiba, v. 14, n. 18, p. 14-23, 2020. Disponível em: <https://www.revistasuninter.com/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/articloe/view/983>. Acesso em: 10 jan. 2026.

GUARDIA, A. N. *et al.* Anotações de enfermagem e qualidade da assistência: vivências da equipe assistencial no contexto hospitalar. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 18, n. 1, e256555, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2024.256555>. Acesso em: 10 jan. 2026.

HORTA, W. A. **Processo de Enfermagem**. São Paulo: EPU, 1979.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. **Projeto pedagógico de curso**: curso técnico em enfermagem (forma subsequente). Curitiba: IFPR, 2023. Disponível em: <https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2024/10/PPC-26-11-1.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. **Resolução nº 39 de 22 de abril de 2010**. Aprova a convalidação do Curso Técnico em Enfermagem – Subsequente. Curitiba: IFPR, 2010. Disponível em: <https://ifpr.edu.br/resolucao-39-2010/>. Acesso em: 20 jan. 2026.

INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES. **The ICN code of ethics for nurses**. Geneva: ICN, 2021. Disponível em: https://www.icn.ch/system/files/2023-04/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. **International patient safety goals**. Oakbrook Terrace: JCI, 2024. Disponível em: <https://www.jointcommission.org/standards/international-patient-safety-goals/>. Acesso em: 27 jan. 2026.

LIMA, E. C.; APPOLINÁRIO, R. S. A educação profissionalizante em enfermagem no Brasil: desafios e perspectivas. **Revista de Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 311-316, 2011. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-601592> . Acesso em: 23 fev. 2026.

LINCH, G. F. C. *et al.* Impacto de uma intervenção educativa na qualidade dos registros de enfermagem. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 25, p. 1-8, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1986.2938>. Acesso em: 27 jan. 2026.

LUDUGERIO, P. I. T. *et al.* Desafios emergentes na educação em enfermagem: uma reflexão da defasagem. **Revista Caderno Pedagógico**, Curitiba, v. 21, n. 4, p. 1-13, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n4-029>. Acesso em: 27 jan. 2026.

MACEDO, L. A.; LOVADINI, V. L.; SAKAMOTO, S. R. A Importância das anotações de enfermagem em prontuários hospitalares: percepção da equipe de enfermagem. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, Rio de Janeiro, v. 92, n. 30, p. 250-257, 2020. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/689>. Acesso em: 11 fev. 2026.

MACEDO, L. C. *et al.* Análise do discurso: uma reflexão para pesquisar em saúde. **Interface – Comunicação, Saúde e Educação**, Botucatu, v. 12, n. 26, p. 649-657, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832008000300015>. Acesso em: 27 jan. 2026.

MARCATTO, I. F. *et al.* Guia educativo para cuidar de adulto crítico com cateter central de inserção periférica. **Texto & Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 33, p. 1-13, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/Mbg3VF6YLBpJTnq6YMcCcGr/?lang=pt> . Acesso em: 27 jan. 2026.

MAZZO, A. *et al.* O uso da simulação clínica no ensino técnico de enfermagem. **Revista Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, v. 33, p. 1-11, 2025. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuernj/article/download/88144/55272/355937?utm_source=chatgpt.com . Acesso em: 11 fev. 2026.

MELARAGNO, A. L. P. *et al.* (org.). **Educação Permanente em Saúde**. Brasília, DF: ABEn, 2023. Ebook. Disponível em: <https://doi.org/10.51234/aben.23.e25> . Acesso em: 26 jan. 2026.

MELO, L. S. *et al.* Efeito do programa educativo na qualidade do registro do Processo de Enfermagem. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 246-253, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900034>. Acesso em: 27 jan. 2026.

MENEGARDE, M.; RODRIGUES, R. M.; CONTERNO, S. F. R. Avaliação da formação no curso técnico em enfermagem de um centro estadual de educação profissional. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 40, e37629, 2024. DOI: 10.1590/0102-469837629. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-469837629>. Acesso em: 11 fev. 2026.

MERHY, E. E. **Saúde**: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.

MILLEN, M. M. V. C. **A importância do prontuário médico na apuração da responsabilidade civil do médico**. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito da Saúde) – Pós-graduação em Direito da Saúde, Universidade Santa Cecília, Santos, 2020.

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

NEGRI, E. C. *et al.* Simulação clínica com dramatização: ganhos percebidos por estudantes e profissionais de saúde. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 25, p. 1-10, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1807.2916>. Acesso em: 05 fev. 2026.

NEVES, R. S. (org.). **Sistematização da assistência de enfermagem (SAE)**: guia para o cuidado organizado. Quirinópolis: IGM, 2020.

OLIVEIRA, V. A. *et al.* Análise da qualidade dos registros de enfermagem: revisão integrativa da literatura. *In*: SEMINÁRIO PESQUISAR, 5., 2016, Aparecida de Goiânia. **Anais** [...]. Aparecida de Goiânia: Faculdade Alfredo Nasser, 2016. Disponível em: https://www.unifan.edu.br/pesquisas/5_pesquisar/. Acesso em: 11 fev. 2026.

ORLANDI, E. P. **Análise de discurso**: princípios e procedimentos. 4. ed. Campinas: Pontes, 2001.

PACHECO, E. Os institutos federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica. *In*: PACHECO, E. (org.). **Os Institutos Federais**: uma revolução na educação profissional e tecnológica. Brasília; São Paulo: Fundação Santillana; Editora Moderna, 2011. p. 13-32.

PAESE, F.; DAL SASSO, G. T. M.; COLLA, G. W. Metodologia de estruturação do Processo de Enfermagem informatizado para as unidades de emergência. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 71, n. 3, p. 1143-1149, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0619>. Acesso em: 14 fev. 2026.

PASTORE, R. T.; FERREIRA, B. J. Formação de técnicos em enfermagem no APH: desafios e perspectivas. **Revista Recien**, São Paulo, v. 14, n. 42, p. 59-71, 2024. DOI: 10.24276/rrecien2024.14.42.5971. Disponível em: <https://doi.org/10.24276/rrecien2024.14.42.5971>. Acesso em: 11 fev. 2026.

PERRENOUD, P. **10 novas competências para ensinar**: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PERTILLE, F.; ASCARI, R. A.; OLIVEIRA, M. C. B. A importância dos registros de enfermagem no faturamento hospitalar. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 12, n. 6, p. 1717-1726, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i6a234419p1717-1726-2018>. Acesso em: 30 jan. 2026.

POPE, C.; MAYS, N. Critical reflections on the rise of qualitative research. **BMJ**, London, v. 339, b3425, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.b3425>. Acesso em: 27 jan. 2026.

REIBNITZ, K. S. *et al.* Reorientação da formação do enfermeiro: análise a partir dos seus protagonistas. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 37, n. esp., p. 1-8, 2016. DOI: 10.1590/1983-1447.2016.esp.68457. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.esp.68457>. Acesso em: 19 fev. 2026.

REPPETTO, M. A.; SOUZA, M. F. Avaliação da realização e do registro da Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE) em um hospital universitário. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 58, n. 3, p. 325-329, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-71672005000300011>. Acesso em: 30 jan. 2026.

RIBEIRO-BARBOSA, J. C. *et al.* Technical schools of the Unified Health System: an analysis of nursing education. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 54, p. 1-8, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018052503580>. Acesso em: 30 jan. 2026.

ROCHA, P. C. S.; PRADO, H. P. O. A formação técnica em enfermagem nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: especificidades, desafios e potencialidades. **Revista Delos**, Curitiba, v. 18, n. 63, p. 1-22, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/rdelosv18.n63-036>. Acesso em: 27 jan. 2026.

ROJAS, F. L. L.; KEHRIG, R. T. Educação permanente em saúde: do ensino ao SUS. **Educação Ciência e Saúde**, Cuité, v. 10, n. 2, p. 70-89, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.20438/ecs.v10i2.461>. Acesso em: 11 fev. 2026.

SALES, B. S. L. *et al.* Registro da assistência pela equipe de enfermagem no prontuário eletrônico do paciente: revisão integrativa. **Revista Enfermagem Atual in Derme**, Rio de Janeiro, v. 99, supl. 1, p. 1-13, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.31011/reaid-2025-v.99-n.supl.1-art.2430>. Acesso em: 27 jan. 2026.

SALVADOR, P. T. C. O. *et al.* Construção de hipermídia para apoio ao ensino da sistematização da assistência de enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**,

Porto Alegre, v. 40, p. 1-10, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180035> . Acesso em: 17 jan. 2026.

SANTANA, N. *et al.* Educação permanente como estratégia para aprimoramento de registros de enfermagem. **Revista Baiana de Enfermagem**, Salvador, v. 33, p. 1-9, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/33378> . Acesso em: 27 jan. 2026.

SANTOS, A. D. *et al.* Causes and mitigation strategies for hospital disallowances: an integrative review. **Seven Editora Acadêmica**, São José dos Pinhais, p. 1-15, 2025. Disponível em: <https://sevenpubl.com.br/editora/article/view/6611>. Acesso em: 27 jan. 2026.

SETZ, V. G.; D'INNOCENZO, M. Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem no prontuário por meio da auditoria. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 313-317, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/BsjcfBf4mRWgD7ZRYGfBJ4F/> . Acesso em: 11 fev. 2026.

SILVA, A. G. I.; DIAS, B. R. L. Registros de enfermagem: uma revisão integrativa da literatura. **Revista Nursing (Edição Brasileira)**, Osasco, v. 21, n. 246, p. 2476-2481, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.36489/nursing.2018v21i247p2476-2481> . Acesso em: 27 jan. 2026.

SILVA, E. M.; ARAÚJO, L. C. B. Relevância da auditoria nos registros de enfermagem: revisão integrativa da literatura. **ID on Line: Revista de Psicologia**, Guararapes, v. 19, n. 77, p. 64-76, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/idonline.v19i77.4213> . Acesso em: 10 jan. 2026.

SILVA, L. P.; FRITZEN, A.; LINCH, G. F. C. Uso de tecnologias para o processo de enfermagem: revisão integrativa. **Journal of Nursing and Health**, Pelotas, v. 13, n. 1, p.1-15, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.15210/jonah.v13i1.24847> . Acesso em: 27 jan. 2026.

SULZBACH, S. R. *et al.* Avaliação dos registros de enfermagem por meio do Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes. **Revista de Enfermagem da UFSM**, Santa Maria, v. 12, p. 1-19, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/2179769268189> . Acesso em: 27 jan. 2026.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

TRINDADE JUNIOR, W. B. **Práticas educativas sobre prescrição de medicamentos por enfermeiros da atenção primária**. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Dourados, 2017.

VILARINHO, J. O. V. **Modelo metodológico para construção de cenários de simulação clínica à luz da Jeffries Simulation Theory**. 2024. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Setor de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

WERMELINGER, M. C. M. W. *et al.* A formação do técnico em enfermagem: perfil de qualificação. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 67-78, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27652019> . Acesso em: 27 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global patient safety action plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705> . Acesso em: 27 jan. 2026.

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem no Ensino Técnico de um Instituto Federal: Construção de um Instrumento para Qualificação da Documentação Clínica”. O objetivo desta pesquisa é desenvolver, com a participação dos docentes do Curso Técnico em Enfermagem do IFPR, um Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem, voltado para estudantes e professores do ensino técnico, a fim de padronizar e qualificar os registros de enfermagem.

A sua participação é totalmente voluntária, e a sua recusa ou desistência não acarretará qualquer prejuízo pessoal, acadêmico ou profissional. A participação não implica em qualquer custo ou despesa. Na pesquisa será realizada uma conversa em grupo, denominada Grupo Focal, que visa coletar percepções e experiências relacionadas à formação técnica e às práticas de anotação de enfermagem. A participação poderá envolver alguns riscos, como desconfortos emocionais ao compartilhar vivências, timidez, ansiedade ou vergonha. Caso isso ocorra, as pesquisadoras estarão disponíveis para acolhimento e escuta qualificada. Ressalta-se que, a qualquer momento, você poderá desistir da participação ou retirar seu consentimento, sem qualquer prejuízo.

Todas as opiniões serão tratadas com respeito e sigilo, sendo assegurado que nenhuma forma de discriminação ocorrerá. Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para o aprimoramento da formação técnica em enfermagem, sobretudo por meio do desenvolvimento de um material didático inédito intitulado *Manual de Boas Práticas em Anotações de Enfermagem*, elaborado de forma a atender às especificidades dos Institutos Federais. Esse material terá como finalidade qualificar os registros de enfermagem, promovendo anotações mais claras, objetivas e padronizadas, em consonância com os princípios éticos e legais da profissão

Os resultados poderão ser divulgados em publicações científicas, eventos acadêmicos e materiais educativos, sempre com a devida preservação do anonimato dos participantes. Nenhum dado que permita sua identificação será divulgado. Todos os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em arquivo, físico ou digital, sob guarda e responsabilidade do/a pesquisador(a), por um período mínimo de 5

(cinco) anos após o término da pesquisa (Resolução CNS nº 510 de 2016, Art. 28, Inciso IV), para que o/a participante possa decidir livremente sobre sua participação e sobre o uso de seus dados no momento e no futuro.

Havendo qualquer dano decorrente da participação na pesquisa, o(a) participante terá direito à assistência imediata e à devida reparação, incluindo indenização, nos termos da legislação vigente, conforme estabelece a Resolução CNS nº 510/2016, Art. 9º, inciso VI. O participante receberá uma via deste Termo de Consentimento, devidamente assinada por ambas as partes.

O projeto foi avaliado pelo CEP UFRGS, órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar - emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição. Meios de contato com o CEP UFRGS: Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria- Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Fone: +55 51 3308 3787 E -mail: etica@gabinete.ufrgs.br Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30h.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, Prof.^a Dr.^a Fabiana Schneider Pires, pelo telefone (51) 99882-1225 ou pelo e-mail fabiana.schneider@ufrgs.br.

Declaro que fui devidamente informado(a) sobre os objetivos, procedimentos, riscos, benefícios e garantias éticas relacionados à minha participação na pesquisa. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo de qualquer natureza.

Curitiba, ____ de _____ de 20__.

Nome do(a) participante: _____

Assinatura do(a) participante: _____

Nome da pesquisadora responsável: _____

Assinatura da pesquisadora responsável: _____

APÊNDICE B – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL

Título da Pesquisa:

Desenvolvimento de um Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem no Ensino Técnico de um Instituto Federal: Um Instrumento para Qualificação da Documentação Clínica

Objetivo do Grupo Focal:

Investigar percepções, experiências e desafios enfrentados pelos professores do curso técnico de enfermagem no que se refere ao ensino da documentação clínica e às estratégias pedagógicas utilizadas para qualificar os registros de enfermagem.

Duração estimada: 60 a 90 minutos

Roteiro de perguntas norteadoras:

1. Como vocês avaliam a abordagem do tema “registros de enfermagem” no currículo técnico atual?
2. Quais são os principais desafios enfrentados pelos alunos na produção de registros clínicos?
3. Você considera que há materiais ou estratégias pedagógicas suficientes para abordar a documentação com qualidade?
4. De que forma os professores são preparados para ensinar sobre anotações de enfermagem?
5. Há práticas inovadoras, como uso de prontuários simulados ou manuais, sendo utilizadas?
6. Como seria, na opinião do grupo, um material ideal para apoiar o ensino dos registros de enfermagem?
7. Quais elementos seriam essenciais em um manual de boas práticas voltado para alunos do ensino técnico?

Encerramento:

Agradecimento aos participantes e esclarecimento de que os dados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, garantindo sigilo e anonimato.

APÊNDICE C – MODELO DE CONVITE AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOCAL

Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba
Curso Técnico em Enfermagem

Prezado(a) Professor(a),

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, de um grupo focal que faz parte da pesquisa de mestrado intitulada:

“Anotações de enfermagem no ensino técnico de um instituto federal: construção colaborativa de um instrumento para qualificação da documentação clínica”.

O objetivo da pesquisa é construir, com base em evidências e na experiência docente, um material didático que possa qualificar o ensino dos registros de enfermagem no contexto técnico.

O grupo focal será realizado nas dependências do campus em dia e horário a ser combinado, com duração estimada de até 90 minutos. Sua participação é fundamental para compreender os desafios enfrentados na prática pedagógica e colaborar com o aprimoramento da formação dos nossos estudantes.

A participação é voluntária e todas as informações serão tratadas de forma sigilosa, conforme os princípios éticos da pesquisa.

Caso aceite participar, solicitamos que confirme sua disponibilidade por e-mail ou presencialmente com a pesquisadora.

Agradecemos desde já pela colaboração.

Atenciosamente,

Mariane Lopes da Silva Guimarães Frota Cordeiro

Mestranda em Ensino na Saúde

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

E-mail: mariane.cordeiro@ifpr.edu.br

CONVITE PARA PARTICIPAR DE PESQUISA

Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem no Ensino Técnico de um Instituto Federal: Construção e Avaliação de um Instrumento para Qualificação da Documentação Clínica



Público-alvo: docentes do curso técnico de enfermagem do IFPR, visando desenvolvimento de um instrumento que qualifique as anotações de enfermagem realizadas pelos estudantes.



Onde: dependências do IFPR.



Duração: cerca de 1h



Quer participar?

Contato: Mariane Cordeiro • email:
mariane.cordeiro@ifpr.edu.br
ou telefone: 51 998821225



ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA

À Direção do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Curitiba,

A pesquisadora Mariane Lopes da Silva Guimarães Frota Cordeiro, CPF 815.271.010-53, solicita a anuência institucional para a realização da pesquisa intitulada *"Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem no Ensino Técnico de um Instituto Federal: Construção e Avaliação de um Instrumento para Qualificação da Documentação Clínica"*, a ser desenvolvida no IFPR – Campus Curitiba.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizará como métodos de coleta de dados questionários e grupos focais com docentes e/ou discentes. Os dados serão analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, e o produto final (manual didático) será validado por painel de especialistas em enfermagem. Os objetivos principais são: identificar fragilidades nas anotações de enfermagem realizadas por estudantes em atividades simuladas e estágios supervisionados; elaborar um manual didático baseado em evidências científicas e normativas profissionais; e validar o material junto a docentes e especialistas da área.

Ressalta-se que os dados coletados serão mantidos em sigilo absoluto, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, e que a pesquisa não interferirá na rotina assistencial ou nas atividades profissionais, em conformidade com o Art. 5º da Resolução 580/2018. Todos os dados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

A instituição Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba, representada pelo(a) abaixo assinado(a), declara ter sido informada sobre os objetivos, metodologia e implicações da pesquisa e concorda com sua realização em suas dependências, fornecendo a infraestrutura necessária para as etapas previstas. Esta autorização está condicionada à aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e ao cumprimento das normativas da Resolução 510/2016 e complementares. A instituição reserva-se o direito de retirar sua anuência a qualquer momento, caso haja descumprimento dos termos éticos estabelecidos.

Curitiba, 14 de maio de 2025.

ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.760.938

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n.º 510, de 2016, e na Norma Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2564478.pdf	17/07/2025 09:50:25		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_mariane_2025.docx	17/07/2025 09:50:12	fabiana schneider pires	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcle_mariane.docx	17/07/2025 09:49:41	fabiana schneider pires	Aceito
Outros	CartarespostaCEP.docx	17/07/2025 09:49:23	fabiana schneider pires	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	carta_anuencia_mariane.pdf	28/05/2025 15:29:24	fabiana schneider pires	Aceito
Folha de Rosto	folha_rosto_manual.pdf	28/05/2025 15:08:44	fabiana schneider pires	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@gabinete.ufrgs.br

INSTITUTO FEDERAL DO
PARANÁ - IFPR



Continuação do Parecer: 7.848.005

modificações, a Emenda, apresentada de forma clara e sucinta, deve ser enviada ANTES de que estas sejam colocadas em prática. Deve-se enviar, também, TODOS OS DOCUMENTOS nos quais houver modificação, destacando nos documentos os trechos modificados. Atentar para a necessidade de alterações no cronograma;

- IMPORTANTE: a pesquisa deve ser realizada em acordo com o que consta e está previsto no protocolo apreciado e aprovado pelo CEP/IFPR. Qualquer modificação realizada no projeto que chegue ao conhecimento do Comitê e que não tenha sido comunicada, via EMENDA, e aprovada pelo CEP/IFPR, poderá resultar em parecer de NÃO APROVADO para o relatório do projeto e será comunicada aos órgãos responsáveis.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_mariane_2025.docx	17/07/2025 09:50:12	fabiana schneider pires	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcle_mariane.docx	17/07/2025 09:49:41	fabiana schneider pires	Aceito
Outros	CartarespostaCEP.docx	17/07/2025 09:49:23	fabiana schneider pires	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Avaliação da CONEP:

Não

CURITIBA, 19 de Setembro de 2025

Assinado por:
SAMUEL RONBO SOARES
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Emílio Bertolini, 54

Bairro: Cajuru

CEP: 82.920-030

UF: PR

Município: CURITIBA

Telefone: (41)3888-5275

Fax: (41)3888-5253

E-mail: cep@ifpr.edu.br

ANEXO C – FICHA TÉCNICA DO PRODUTO EDUCACIONAL

Elemento	Descrição
Descrição do produto	Manual pedagógico voltado ao ensino das anotações de enfermagem no curso técnico, elaborado com base nas evidências empíricas do grupo focal, nas normativas profissionais vigentes e em referenciais teórico-pedagógicos da educação profissional em saúde. O manual apresenta orientações didáticas, exemplos comentados, organização por áreas clínicas e estratégias de apoio ao desenvolvimento das competências documentais dos estudantes.
Finalidade do produto	Qualificar o ensino-aprendizagem das anotações de enfermagem na formação técnica, promovendo a compreensão do registro como parte integrante do cuidado, do raciocínio clínico e das responsabilidades ético-legais da profissão.
Público de interesse	Docentes e estudantes do Curso Técnico em Enfermagem do Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba.
Forma de divulgação do produto	Utilização institucional no Curso Técnico em Enfermagem do IFPR – Campus Curitiba, com possibilidade de compartilhamento interno para fins pedagógicos.
Vinculação ao projeto de pesquisa	Produto educacional resultante da pesquisa intitulada ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO ENSINO TÉCNICO DE UM INSTITUTO FEDERAL: construção colaborativa de um instrumento para qualificação da documentação clínica
Linha de pesquisa	Processo de Ensino na Saúde.
Forma de disponibilização	Disponibilização institucional no Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba, em formato digital, para uso didático-pedagógico.
Autoria	Mariane Lopes da Silva Guimarães Frota Cordeiro.
Orientação	Fabiana Schneider Pires.
Ano	2026.

ANEXO D - TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ

CEDENTE: Nome: _____ CPF: _____

Assinatura:

CESSIONÁRIO: Mariane Lopes da Silva Guimarães Frota Cordeiro CPF: _____

Assinatura:

OBJETO: O cedente autoriza, de forma gratuita e irrevogável, a utilização de sua imagem e voz captadas durante grupo focal realizado em _____ (data), para fins exclusivamente acadêmicos e educacionais relacionados à pesquisa "Manual de Boas Práticas para Anotações de Enfermagem no Ensino Técnico de um Instituto Federal", vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

FINALIDADE: Utilização em dissertação de mestrado, produto educacional, apresentações acadêmicas e publicações científicas derivadas da pesquisa.

PRAZO: Indeterminado.

TERRITÓRIO: Nacional e internacional.

CONDIÇÕES: A cessão é gratuita, não exclusiva e irrevogável. O cessionário compromete-se a utilizar a imagem e voz de forma ética, respeitando a integridade e dignidade do cedente.

FORO: Curitiba/PR.

Local e Data Local e Data